

Utredning av en integrert ungdomstjeneste på ett nivå

Svar på oppdrag i TB2024-25 og klargjøring av oppdrag i TTB2024-26

Innhold

1. Sammendrag	3
2. Bakgrunn	6
3. Metode	8
4. Dagens situasjon	9
4.1 Utfordringer blir ikke fanget opp tidlig nok	10
4.2 Hjelpen som gis tar ikke utgangspunkt i barnas behov	11
4.3 Manglende samarbeid mellom tjenestetilbud	12
4.4 Konsekvenser	13
5. Samfunns- og effektmål	13
6. Relevante tiltak	14
6.1 Nullalternativet	15
6.2 Økt andel rammefinansiering i PHBU og TSB	16
6.3 Felles plan i helsefelleskap	16
6.4 Avklaringsteam i kommunen	18
6.5 Avklarings- og inntaksteam forankret i helseforetaket	20
6.6 Integrert helsetjeneste – En felles helsetjeneste på ett nivå	21
6.7 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?	22
7. Virkningsanalyse	23
7.1 Identifiserte berørte aktører og virkninger	24
7.2 Verdsetting av virkninger	27
7.3 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet	30
7.4 Usikkerhetsanalyse	32
8. Anbefaling og forutsetninger for en vellykket gjennomføring	32
9. Litteraturliste	33

1. Sammendrag

Helsedirektoratet fikk i 2024 i oppdrag å utrede en pilot for en integrert ungdomstjeneste på ett nivå. Formålet med oppdraget er å sikre at barn og unge får helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset deres behov, og å styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utredningen omfatter også vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser.

Det pågår mange andre tilgrensende og overlappende tiltak med tilsvarende målsetting og målgruppe. Prosjekt X samler utvalgte prosjekter der kommuner og sykehus i fellesskap tester ut nye måter å organisere tjenestene på (integreerte tjenester). Noen av disse prosjektene omhandler psykisk helse og rus. Helsedirektoratet vil følge med på pilotene i Prosjekt X, og har fått i oppdrag å oppsummere erfaringer og læringspunkter, jf. oppdrag 107 i Supplerende tildelingsbrev nr. 5.

For å sikre et bredest mulig bilde av utfordringene for barn, unge og deres pårørende ble det i forbindelse med dette oppdraget gjennomført et innsiktsarbeid. Innsikten er ikke uttømmende, men gir et situasjonsbilde og avdekker sentrale utfordringer basert på arbeidsmøter og intervjuer med både brukere, kommuner og spesialisthelsetjenesten (BUP).

Innsiktsarbeidet viste at mange barn og unge opplever at psykiske helse- og rusmiddelutfordringer ikke fanges opp tidlig nok. Tjenestene oppleves som fragmenterte, og det er store variasjoner mellom kommuner. Manglende samarbeid og informasjonsdeling gjør at barn og unge ofte opplever å bli kasteballer mellom ulike instanser. Innsiktsarbeidet støtter dermed behovet for bedre integrering av tjenestene. Hjelpen som gis er ofte lite tilpasset individuelle behov, og brukerinvolveringen er svak. Strukturelle barrierer som finansieringsmodeller, juridiske rammer og mangel på personell forsterker utfordringene.

Konsekvensene av manglende tidlig innsats og fragmenterte tjenester er alvorlige. Barn og unge risikerer forverring av helseproblemer, skolefravær, tidlig uførhet og utenforskap. Dette medfører store samfunnskostnader og belastning for pårørende og helsepersonell.

Utredningen har definert et samfunns mål om bedre helse og økt livskvalitet for barn og unge gjennom mer bærekraftige og integrerte tjenester. I tillegg er det utarbeidet to effektmål:

- 1) Bedre helse og livskvalitet for målgruppen
- 2) Mer effektiv ressursbruk i tjenestene

Det er utarbeidet flere tiltaksalternativ som kan bidra til å løse utfordringene som ble avdekket i innsiktsarbeidet, og som vil kunne bidra til å nå disse målene gjennom ulik integrering av tjenestene. Innspill om innhold og antatte virkninger ble innhentet fra brukere, helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten, og disse, sammen med statistikk, eksisterende forskning og annen kunnskap, har blitt brukt som underlag for å kunne vurdere nytte og kostnader for de ulike tiltaksalternativene. Hva som må til for en vellykket gjennomføring av de ulike tiltakene, herunder faglig normerende, juridiske og finansielle virkemidler, er også beskrevet.

De fire hovedtiltakene som er virkningsvurdert er:

- Økt rammefinansiering i psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

- Felles plan i helsefellesskapene
- Avklaringsteam i kommunen
- Avklarings- og inntaksteam forankret i helseforetaket.

I tillegg er felles plan og en av teammodellene kombinert i en tiltakspakke. Virkningsanalysen viser at kombinasjonstiltaket gir størst samfunnsøkonomisk nytte. Tiltaket gir bedre helse og livskvalitet for barn og unge, økt jobbtillfredshet for helsepersonell og frigjør tid i spesialisthelsetjenesten. Kostnadene inkluderer kostnader for kommuner og helseforetak knyttet til utarbeidelse av felles plan og møtevirksomhet i team. Resultatene fra virkningsanalysen er oppsummert i tabellen under. Røde tall indikerer kostnader, og grønne tall indikerer nytte.

Tabell 1-1: Oppsummering av prissatte virkninger, summert for analyseperioden på 10 år, i millioner 2025 kroner, ikkeprissatte virkninger og rangering av tiltak

Nytte- og kostnadselement	Økt andel ramme PHBU	Felles plan i helsefellesskapet	Avklaringsteam i kommunen	Avklarings- og inntaksteam	Kombinasjon team, felles plan
PRISSATTE VIRKNINGER					
Sum kostnader	13	66	213	179	245 - 279
Sum nytte	18 - 55	14	40	0	14 - 54
Skattefinansieringskostnad/-gevinst	1 - 9	10	35	36	45 - 46
Netto nåverdi av prissatte virkninger	6 - 51	63	207	214	270 - 277
IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER					
Bedre helse for barn/unge og pårørende	Usikker	Middels positiv	Stor positiv	Stor positiv	Meget stor positiv
Økt jobbtillfredshet	Liten positiv	Liten positiv	Liten positiv	Liten positiv	Middels positiv
Ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet	Usikker	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
RANGERING	4	3	2	2	1

Det ble også utarbeidet et tiltaksalternativ som ble kalt "En felles helsetjeneste på ett nivå". Innspill til dette alternativet ble innhentet i innspillsrunden, og basert på tilbakemeldingene ble det vurdert at tiltaket måtte detaljeres ut for at det skulle være mulig å gi konkrete vurderinger av potensielle virkninger av tiltaket. Alternativet ville medført store endringer og en detaljering ville innebære mange forbehold om uavklarte forhold. Parallelt med disse vurderingene ble Helsereformutvalget opprettet, med mandat om å vurdere et slikt alternativ. I samråd med Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor vårt tiltak parkert, med en mulighet for å utrede det videre på et senere tidspunkt.

Det kan også vurderes andre alternativer for integrering som ikke er så omfattende som "En felles helsetjeneste på ett nivå". Andre alternativer kan inkludere delte stillinger og felles lokaler mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, hvor man integrerer tjenestene på en helt annen måte enn om BUP og kommuner arbeider hver for seg. Dette vil kunne underbygge tiltaksalternativene som er beskrevet i rapporten, og hvor det også kan være aktuelt med felles avklaringsteam for både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Det kan også vurderes om spesialisthelsetjenesten kan ta et større ansvar for pasientgruppen og at kommunen legger inn sine ressurser slik at spesialisthelsetjenesten kan ta et mer helhetlig ansvar. Ved pilotering vil det i så fall være aktuelt å gjøre unntak fra gjeldende regelverk med hjemmel i forsøksloven. Dette er heller ikke forhold som er utredet videre, da enkelte av pilotene i Prosjekt X vil dekke slike alternativer. Helsedirektoratet vil som angitt følge med på pilotene i prosjekt X og oppsummere erfaringer og læringspunkter.

Anbefaling

Basert på resultatene fra virkningsvurderingen anbefales det at kombinasjonstiltaket felles plan og en av teammodellene piloteres i utvalgte kommuner og evalueres før eventuell bredere implementering. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring er tydelig rolleavklaring, lederforankring og god kommunikasjon mellom aktørene. Digitale samhandlingsløsninger kan styrke effekten ytterligere.

Det er kun felles plan i helsefellesskapet og en av de to teammodellene som anbefales gjennomført i denne omgang, da utredningen viser at det er uklar virkning av tiltaket om økt rammefinansiering i psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

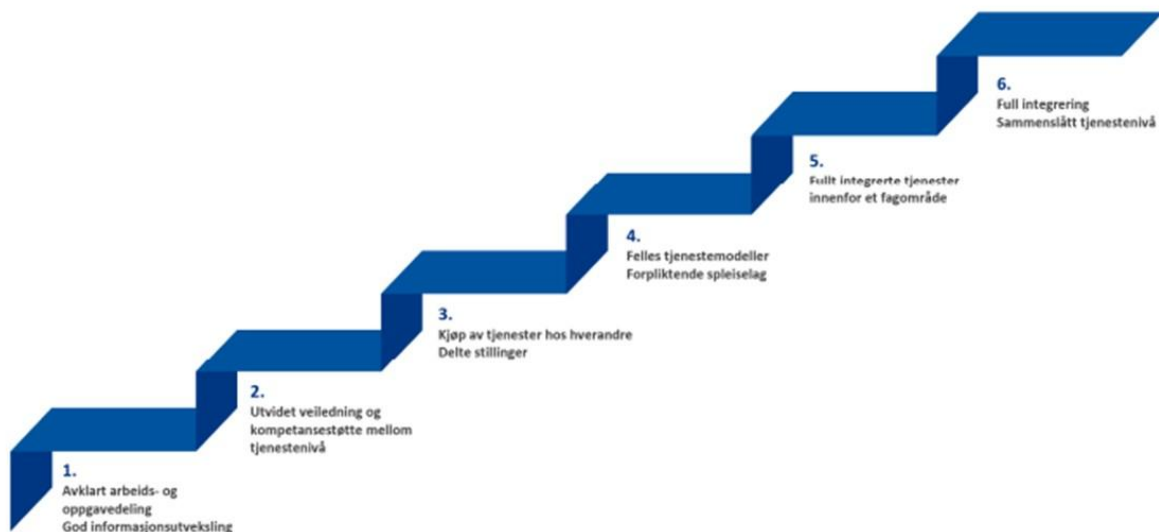
2. Bakgrunn

Oppdrag og mandat

I tildelingsbrevet for 2024 [1] fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede og foreslå hvordan en pilot for en integrert ungdomstjeneste på ett nivå kan innrettes og etableres, samt å gjennomføre en følgeevaluering. Oppdraget omfatter en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser.

Målet er å sikre at barn og unge får helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset deres behov. Dette inkluderer blant annet å styrke samarbeidet mellom ulike tjenestenivåer og sektorer, samt å sikre at barn og unge får tilgang til nødvendig hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.

WHO definerer integrerte helsetjenester som kontinuerlige, koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester som kombinerer ulike nivåer og typer helsetjenester [2]. I rapporten «Tid for samordning» gir Helse Nord en god beskrivelse av ulike nivå for integrering, visualisert i figuren under [3].



Helsedirektoratet har tolket oppdraget som en utredning av tiltak på systemnivå. En utredning og beskrivelse av tjenestetilbudet til det enkelte barn eller ungdom ville forutsatt en annen tilnærming i innsiktsarbeidet og i tiltaksutviklingen. Videre har Helsedirektoratet i tråd med utredningsinstruksen og veileder i samfunnsøkonomiske analyser identifisert og utredet flere forskjellige typer tiltak, inkludert tiltaksforslag på ulike nivåer i integreringsstigen, og ikke kun full integrering med ett sammenslått tjenestenivå.

Utfordringsbildet

Riksrevisjonens undersøkelse [4] viser at mange med psykiske plager og lidelser ikke får hjelp når de trenger det og ungdommer med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer får ikke god nok behandling. Også andre rapporter har vist at barn og unge med symptomer på psykiske plager eller lidelser eller rusmiddelutfordringer, ikke får den hjelpen de

trenger. Tjenestene oppfattes som fragmenterte og lite tilgjengelig fordi det enten mangler et tilbud eller er vanskelig å finne frem i en jungel av informasjon og tiltak.

Politisk kontekst

Oppdraget om å utrede en integrert tjeneste på ett nivå er et resultat av flere prosesser. En målsetting i

Opptrappingsplanen for Psykisk helse er å bidra til at flere skal få god og lett tilgjengelig hjelp [5]. Planen påpeker at tjenestetilbudet til barn og unge med psykisk helseutfordringer er godt utbygget, men at flere rapporter viser at mange ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den. Barn og unge har mer sammensatte plager og

Opptrappingsplanen viser til behovet for mer integrerte tjenester som kan møte disse utfordringene på en helhetlig og koordinert måte. Noen av tiltakene i planen er at modeller for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og integrert ungdomstjeneste på ett nivå skal utredes og piloteres for unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og inkludere tverrsektorielt samarbeid.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan omtaler oppdraget til regionale helseforetak i 2024 om å legge til rette for utprøving av samarbeid mellom helseforetak og kommuner og Helsedirektoratets oppdrag om å utrede et integrert tilbud for barn og unge [6] under utprøving og innføring av nye organiseringsformer for bedre sammenheng i tjenestene. Også del 1 av Forebyggings- og behandlingsreformen viser til Opptrappingsplanen for psykisk helse og utredning av en integrert ungdomstjeneste [7].

Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt for å foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell for å dekke økende behov i helse- og omsorgstjenestene. Et flertall i kommisjonen [7] anbefalte å utrede en mer helhetlig organisering av helse- og omsorgstjenestene, eventuelt samlet på ett felles forvaltningsnivå. De mente dette ville redusere forbruket av helsepersonell og gi bedre bruk av den samlede tilgjengelige kompetansen i helse- og omsorgstjenestene.

Avgrensning og målgruppe

Denne utredningen har hovedfokus på psykisk helse- og rustjenester og tiltakene er avgrenset mot somatiske helsetjenester og andre sektorer som barnevern, skole og NAV. En tverrsektoriell tilnærming har vært vurdert, men oppdraget er kun gitt til Helsedirektoratet, uten mandat til å legge føringer for andre sektorer. Helsedirektoratets oppfatning er videre at det også er behov for å ta tak i utfordringer mellom systemnivåene i helsetjenesten, og vi har tolket oppdraget dithen at det fokuserer på disse utfordringene. Det er imidlertid behov for å jobbe parallelt med samarbeid og samhandling på tvers av sektorer for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge.

Helsedirektoratet har valgt en åpen utredning, med utredningsinstruksen og systemorientert design som utgangspunkt. Oppdragsteksten omtaler ungdom, men prosjektet valgte å ikke avgrense målgruppen, og innsiktsarbeidet har rettet seg mot barn og unge med psykisk helse- og rusmiddelproblemer, uten ytterligere avgrensning av aldersgruppen. Det har ikke fremkommet noe i innsiktsarbeidet eller tiltaksutviklingen som har avgrenset aldersgruppen for de ulike tiltakene. For praktiske formål kan det likevel være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en øvre aldersgrense, f.eks. for å beregne grunnlag for rammefinansiering. En øvre aldersgrense på 25 år vil være i samsvar med FACT ung sin aldersgruppe og man unngår mulige utfordringer med egenandel i psykisk helsevern og TSB.

Det er heller ikke gjort noen ytterligere avgrensning av tilstander eller alvorlighetsgrad i målgruppen. En risiko ved dette er at brukerinvolvering og innsiktsarbeidet ikke fanger opp barn og unge med de mest alvorlige psykiske lidelsene og/eller rusmiddelproblemene. Helsedirektoratet har akseptert denne usikkerheten, og er kjent med at flere planlagte og pågående prosesser retter seg direkte mot unge med store utfordringer. Universelle og indikative tiltak kan derfor være et viktig supplement som gir positive effekter også for de med størst utfordringer. Prosessen med utvikling av tiltaksalternativer har resultert i alternativer som primært retter seg mot en gruppe i mellomstadiet; barn og unge hvor det er usikkerhet om alvorlighetsgrad eller med sammensatte plager og behov for flere tjenester samtidig.

Prosjektorganisering og aktørinvolvering

Prosjektet har vært organisert med en intern arbeidsgruppe med bred kompetanse fra Helsedirektoratet, samt involvering av eksterne aktører gjennom ekstern arbeidsgruppe og referansegruppe. Aktørinvolvering har vært sentralt i alle faser, fra innsiktsarbeid til samskapning og innspillrunde. For å sikre bredde i perspektiver har vi inkludert helsepersonell fra både store og små kommuner og spesialisthelsetjenesten, kompetansemiljøer, statsforvalter og barneombud, samt representanter fra representanter fra bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner. Mer om prosjektets organisering finnes i vedlegg 1.

Tilgrensende prosjekter

Det pågår mange ulike prosesser som må ses i sammenheng med utredningen av en integrert ungdomstjeneste. Identifiserte tilgrensende prosjekter og avhengigheter beskrives nærmere i vedlegg 2. Noen sentrale prosesser er Prosjekt X, Helsereformutvalget, implementering av veileder for psykisk helsearbeid i kommunene og RHF-enes oppdrag om å legge til rette for vurderingssamtaler og utprøving av samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Det var viktig for prosjektet å ha god oversikt over sentrale tilgrensende prosesser og avhengigheter for å unngå dobbeltarbeid, og fordi de ulike prosessene kan påvirke hverandre ved at de har helt eller delvis overlappende målgrupper. Målet er å legge til rette for å se prosessene i sammenheng slik at de understøtter hverandre, for å sikre effektiv ressursbruk og optimalisere effektene.

Kapittel 3

3. Metode

Prosjektet har tatt utgangspunkt i utredningsinstruksen og benyttet metodikk fra tjeneste- og systemorientert design. Dette har gjort det mulig å utforske både brukernes behov og de strukturelle forholdene som påvirker tjenestene, og har sikret at tiltaksalternativene er godt dokumentert og forankret. Arbeidet har fulgt en prosess som kan beskrives av den doble diamanten, som legger til rette for både bred utforsking og målrettet problemløsning. Prosessen var delt inn i fire faser som er beskrevet nedenfor. En mer detaljert beskrivelse finnes i vedlegg 3.

Utforske utfordringsbildet

Prosjektet begynte med en bred innsiktsfase der vi innhentet og sammenstilte kunnskap fra workshops, intervjuer, ungdomspaneler og eksisterende litteratur for å få en helhetlig forståelse av situasjonen. I workshopene kartla den interne arbeidsgruppen i samarbeid med ekstern arbeidsgruppe aktørlandskapet, brukerscenarioer, utfordringer i helsetilbudet og underliggende årsaker. For å få dybdekunnskap om hvordan utfordringene oppleves av pasienter, pårørende og helsepersonell gjennomførte vi 17 intervjuer med involverte aktører. Innsikten ble supplert med ungdommenes egne perspektiver innhentet gjennom kontakt med ungdomspanelene DigiUng og i IMDi. En gjennomgang av relevante rapporter og offentlige utredninger tillot oss å validere funn og avdekke kunnskapshull.

Formulere problemforståelse og sette mål

Når alle innsiktsaktivitetene var blitt gjennomført ble funnene sammensatt og sortert tematisk for å identifisere noen problemområder, som også ble forankret med referanse- og styringsgruppen. Dette la grunnlaget for utfordringene som presenteres i kapittel 4 om dagens situasjon. Basert på denne problemforståelsen definerte man også et samfunns mål og tilhørende effektmål som satte retning for det videre arbeidet i prosjektet.

Utvikle tiltaksforslag

I arbeidet med å identifisere relevante tiltak startet prosjektet med en åpen utforskning av mulighetsrommet, definert av problem, mål og rammebetingelser. Dette er viktig for å unngå å binde seg til ett eller noen få tiltak tidlig i prosessen.

Tiltaksutviklingen skjedde gjennom samskappingsworkshops med både intern og ekstern arbeidsgruppe, der deltakerne genererte og prioriterte tiltak. Deretter stilte prosjektgruppa etter en intern arbeidssamling bort de tiltakene som, basert på en foreløpig vurdering, ville gi svært lav måloppnåelse og detaljerte ut de tiltakene som skulle tas med videre i utredningen. Disse tiltakene er beskrevet i kapittel 6.

Vurdering og anbefaling

Etter en bred utforsknings- og utviklingsfase ble tiltaksalternativene vurdert. Det er innhentet innspill om tiltakenes innhold og antatte virkninger gjennom en spørreundersøkelse og intervjuer med helsepersonell og brukere. Positive og negative virkninger ble deretter systematisert og verdsatt, enten kvalitativt eller kvantitativt. Resultatene fra denne virkningsanalysen er beskrevet i kapittel 7. Anbefalingen av tiltak beskrevet i kapittel 8 er basert på en vurdering av hvilket tiltak eller tiltakskombinasjon som gir størst samlede positive virkninger i forhold til samlede negative virkninger for samfunnet.

Kapittel 4

4. Dagens situasjon

Overordnet beskrivelse av utfordringsbildet

Psykiske plager og lidelser er en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge, og barn og unges psykiske helse har vært gjenstand for politisk fokus over flere år. Selvrapporteringer har vist en økning i psykiske plager blant unge over lang tid [8]. Norske helseregistre viser også en økning i andel barn og unge som er i kontakt med helsetjenesten grunnet psykiske problemer [8].

Årsakene til økningen er sammensatte og komplekse, men faktorer som ensomhet, skolerelatert stress og søvnvansker antas å være sentrale [8]. Ungdata viser imidlertid relativt stabile tall de siste årene, dersom man ser bort fra pandemien, med unntak for jenter på videregående [9]. Andelen utsatt for mobbing, mistrivsel i skolen og skolevegring, rusmiddelbruk og ulike helseutfordringer er fortsatt økende [9]. Det er også en økning i unge uføre, med bakgrunn i økt forekomst av psykiske helseplager, men også pga. høyere kompetansekrav i arbeidslivet [10].

Tilbudet til barn og unge som har rusmiddelproblemer og/eller psykiske plager eller lidelser er mangelfullt både i kommunesektoren og i spesialisthelsetjenesten [7]. Dette øker risikoen for at problemer hos barn og unge ikke avdekkes tidlig nok og at de dermed ikke får nødvendig, relevant og effektiv helsehjelp.

Likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av diagnose, alder og bosted er et viktig helsepolitisk mål.

Undersøkelser viser at det er variasjon i tilgang til psykiske helsetjenester og behandling, avhengig av bosted [7].

Sintef-rapport Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid [11] sier følgende om situasjonen i kommunene:

- 67 kommuner/bydeler har ikke egne årsverk for barn og unge i målgruppen for psykisk helse- og rusarbeid. Andelen som svarer nei på dette spørsmålet, er høyest i små kommuner.
- 142 kommuner/bydeler (41 prosent) har ikke en tverrfaglig psykisk helsetjeneste, utenom fastlegeordningen og helsestasjon- og skolehelsetjenesten, for tidlig hjelp og behandling til barn og unge med psykisk helse og rusmiddelproblemer. 80 kommuner oppgir imidlertid at de har planer om å opprette en slik tjeneste.
- Nedgang på 110 årsverk nasjonalt i tjenester til barn og unge i målgruppen fra 2023 til 2024, tilsvarende 2,9 prosent. Merk at denne endringen er usikker, på grunn av tidsseriebrudd.

- 12 prosent av kommuner/bydeler svarer at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten om barn og unge med alvorlige langvarige problemer/lidelse fungerer dårlig eller svært dårlig, mens 40 prosent svarer at det fungerer nokså godt. Her er det med andre ord rom for forbedring.

Helsepersonellet utgjør den viktigste delen av helse- og omsorgstjenestene [12]. Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for at sykehus og kommuner skal kunne tilby helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Norge står, i likhet med andre land, overfor store utfordringer med tilgang på personell fremover.

4.1 Utfordringer blir ikke fanget opp tidlig nok

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er avgjørende for å hindre at psykiske helse- og rusmiddelutfordringer utvikler seg til mer alvorlige tilstander. Innsiktsarbeidet viser at mange barn og unge ikke oppsøker hjelp tidlig nok, og at det er vanskelig å skille mellom vanlige plager og der det er behov for helsehjelp.

Det er vanskelig for barn og deres pårørende å vite hvor man skal henvende seg for hjelp

Innsikten viser at barn, unge, pårørende og helsepersonell ofte mangler oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes, hva man har rett på, og hvordan man får tilgang til hjelp [13, 14]. Selv om tilbud som helsestasjon for ungdom og nettsiden Ung.no er godt kjent, opplever mange fortsatt at det er uklart hvor man finner relevant informasjon om tjenestetilbudet der de bor. Det påpekes også at pårørende og andre rundt barn og unge kan se ulike tegn til bekymring, men det kan være vanskelig å vite hvor man kan henvende seg [15]. Tjenestene kan oppleves fragmenterte og at ingen har ansvar for helheten, noe som kan medføre at bekymringer ikke tas videre.

Høy terskel for barn og unge å oppsøke helsehjelp

Stigma og skam er sentrale barrierer, særlig for unge med rusmiddelutfordringer. Mange vegrer seg for å søke hjelp, og noen opplever å bli møtt med stigma fra helsepersonell. For mange unge oppleves ikke rusmiddelbruken som et problem, men snarere som en måte å håndtere andre utfordringer. Frykt for sanksjoner og usikkerhet rundt taushetsplikt, spesielt på mindre steder, bidrar ytterligere til at hjelp ikke oppsøkes. Ungdomspanelene peker på behovet for tydeligere informasjon om rettigheter og trygghet i møte med helsetjenesten. Dette understøttes også av forebyggings og behandlingsreformen [6]. Innsikten fra workshop og intervjuer med helsepersonell fremhever behovet for arenafleksible og oppsøkende tjenester som møter barn og unge der de er. Dette støttes også av flere rapporter [16, 17].

Manglende oppfølging i kommunen i påvente av utredning

Barn og unge med psykiske plager må ofte vente lenge før de får hjelpen de trenger. Dette gjelder spesielt ved moderate tilstander der det er uklart hvem som har ansvaret for å tilby hjelp. Innsikten peker på at dette blant annet skyldes manglende rutiner i kommunen ved avslag fra spesialisthelsetjenesten, hvor det ofte ikke settes inn alternative tiltak. Konsekvensen er at barn og unge kan oppleve forverring av plagene, miste tillit til hjelpeapparatet, eller falle helt ut av oppfølging [15,18; se Vedlegg 4]. Lange ventetider i påvente av utredning eller annen behandling i BUP uten at det settes i gang andre tiltak i mellomtiden kan også føre til plagene forverres [13].

Uforutsigbar finansiering av lavterskel og forebyggende tilbud

I tillegg til individuelle barrierer, viser innsikten at strukturelle forhold i tjenestene også bidrar til at utfordringer ikke fanges opp tidlig. Kommunene har stor frihet til å vurdere hvordan de skal innrette tjenestene sine for å ivareta forsvarlighetskravet. Tidligere rapporter peker på at lovpålagte tjenester ofte prioriteres fremfor lavterskel og oppsøkende tilbud [14,15,17]. Behovet for forebyggende arbeid fremheves i samtlige intervjuer, og støttes av sluttrapporten «Mind the gap!» fra 0-24 samarbeidet [19]. Stram kommuneøkonomi, pressede tjenester og manglende politisk prioritering trekkes frem som årsaker

til nedprioritering av forebyggende innsats, til tross for bred faglig enighet om nytteverdien. Manglende øremerking av midler til forebygging gjør det vanskelig å prioritere tidlig innsats over lovpålagte tjenester [14,15,17; se Vedlegg 4].

4.2 Hjelpen som gis tar ikke utgangspunkt i barnas behov

Barn og unge med behov for helsehjelp bør møtes med støtte og hjelp tilpasset deres livssituasjon. Innsikten viser imidlertid at mange opplever et system som er lite fleksibelt, at de ikke blir lyttet til og at hjelpen i for liten grad er tilpasset deres individuelle behov.

Fokus på utredning og kartlegging framfor omsorg i møte med barn og unge

I innsikten fra workshopene ble det trukket fram at ungdom i møte med helsetjenestene opplever at det er mye fokus på utredning og kartlegging fremfor faktiske tiltak som gjør hverdagen bedre. Det trekkes også frem at språket som brukes i helsetjenesten kan oppleves som fremmed og vanskelig å forstå. Tidligere rapporter understreker behovet for å forstå kompleksiteten i utfordringene barn og unge står i [14]. I workshopene ble det trukket frem at opplevelsen av god hjelp knyttes til å bli sett og fulgt opp over tid, noe som utfordres av korte behandlingsløp og stor utskifting av helsepersonell.

Manglende støtte for medvirkning og kommunikasjon med brukeren

Barn og pårørende beskriver manglende involvering i beslutninger som angår dem [14, 20, 21; se Vedlegg 4]. Dette svekker både tilliten og relasjonen til hjelperne, og skaper en opplevelse av mindre trygghet og mestring [13]. Innsikten peker også på at barn, unge og deres pårørende opplever at de ikke får god nok informasjon om hva som følges opp og av hvem. Tjenesteytere trekker frem manglende støtte for digital dialog som en barriere for effektiv kommunikasjon og samhandling med sluttbruker [14; se Vedlegg 4]. Tidligere rapporter beskriver også at Individuell plan (IP) ofte ikke lykkes med intensjonen om å sikre koordinering, grunnet manglende integrasjon mellom fagsystemer og at mange brukere ikke er klar over at de har rett til en slik plan [13, 14].

Begrensninger i lovverket og finansielle styringssystemer

Helsepersonell opplever at økonomiske styringsmodeller og juridiske rammer begrenser muligheten til å gi den hjelpen de mener er nødvendig. Finansieringsmodeller som ikke reflekterer den faktiske innsatsen og verdien for brukeren, kombinert med høye krav til effektivitet, gjør at aktiviteter som gir stor verdi for brukeren, men som er tidkrevende eller ikke gir økonomisk uttelling, ofte nedprioriteres [15; se Vedlegg 4]. Krav om samtykke til informasjonsdeling, eller når den unge ikke ønsker hjelp etter å ha blitt helserettslig myndig, kan i noen tilfeller begrense muligheten til å gi nødvendig psykisk helsehjelp. Dokumentasjonsplikten begrenser også hvem som kan gi lavterskel hjelp for unge som ønsker å være anonyme [22].

Store variasjoner i tjenestetilbudet mellom ulike kommuner

Det er store variasjoner i tjenestetilbudet mellom kommuner, særlig innen oppsøkende arbeid og lavterskeltjenester. Dette fører til ulik praksis for hvem som får hjelp og hva slags hjelp som tilbys [4, 11, 20]. Særlig mindre kommuner har utfordringer med å bygge opp tjenestetilbud til personer med sammensatte behov som krever spisset kompetanse og tverrfaglig innsats [15; se Vedlegg 4]. Innsikten viser at til tross for nasjonale føringer for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, ser det ut til at variasjon i kommunale tilbud fører til ulik praksis for henvisning [23, 24, 25].

4.3 Manglende samarbeid mellom tjenestetilbud

Barn og unge med sammensatte behov opplever ofte at ingen tar helhetlig ansvar for hjelpen de får. Manglende samarbeid, koordinering og uklar ansvarsfordeling fører til at tjenestene vurderer behov ut fra eget mandat, noe som gir fragmentert hjelp og gjør at brukerne opplever å bli en kasseball mellom instanser [13, 14].

Manglende verktøy for effektiv deling av informasjon mellom tjenester

Mange behandlere har behov for den samme informasjonen, men opplever at eksisterende løsninger for informasjonsdeling er utilstrekkelige. Dette fører til dobbeltarbeid og frustrasjon for barn som må gjenta sin historie flere ganger [14, 15, 17; se Vedlegg 4]. Taushetsplikten oppleves som en barriere, særlig grunnet usikkerhet hos helsepersonell rundt tolkning av regelverket [13; se Vedlegg 4]. Helsepersonell forteller at dette fører til at informasjonsdeling basert på samtykke i mange tilfeller kun gjøres ved alvorlige tilfeller, selv om det kunne vært nyttig også ved mindre plager. Pårørende beskriver også overgangen til at den unge blir helserettslig myndig som utfordrende, da de mister innsyn i informasjon om den unge med mindre det innhentes samtykke.

Uklare skiller mellom tjenestenivåene

Innsikten peker på at overgangen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ofte preges av uklar ansvarsfordeling. Dette gjelder særlig dem med moderate plager, som opplever å falle mellom nivåene - de er for syke for kommunen, men ikke syke nok for spesialisthelsetjenesten. Uklarhet i overgangene fører til at ansvar skyves mellom tjenestenivåer, uten at noen sikrer at barnets behov blir ivarettatt [13; se Vedlegg 4]. For unge med rusmiddelproblemer forsterkes utfordringen av at det er stor variasjon i hvilke tilbud og kompetanse som er tilgjengelig i de ulike kommunene og helseforetakene. Oppfølgingen etter kontakt med spesialisthelsetjenesten er også mangelfull, blant annet grunnet manglende oversikt over hvilke kommunale tilbud den enkelte har tilgang til.

Ulik forståelse av hva som er problemet og oppfatninger om behov, mandat og lovverk

Tjenestene har ulike mandat, lovverk og profesjonsbakgrunn, noe som fører til ulike oppfatninger av hva som er problemet og hva slags hjelp som trengs. Manglende felles språk og profesjonskamp kan hindre samarbeid og helhetlig forståelse [13, 14; se Vedlegg 4]. Resultatet er at barn og pårørende opplever å bli en kasseball mellom tjenester, eller at hjelpen ikke henger sammen. Dette er spesielt utfordrende i grenseflatene mellom psykisk helse og rus for de over 18 år og mellom barnevern og BUP for de under 18 år. Begrenset tilgang til spesialisert rusbehandling for unge under 18 år og at tilbudet varierer betydelig mellom kommuner forsterker utfordringen.

Finansieringssystemet i PHBU og TSB belønner ikke samarbeidsaktiviteter tilstrekkelig

Samarbeid med tredjeparter utenfor spesialisthelsetjenesten er pålagt gjennom lovverk og føringer. Det foreligger også noe finansiering knyttet til samarbeidsaktiviteter og integrerte team (ACT/FACT) mot enkeltpasienter i ISF. Det fremkommer imidlertid i intervjuer med helsepersonell at de mener finansieringssystemet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at dette prioriteres. Mangel på tverrfaglig kompetanse, tid og ressurser gjør samarbeid krevende, og finansieringsmodeller legger ikke i tilstrekkelig grad til rette for et helhetlig ansvar. Dette bidrar til at samarbeid nedprioriteres siden det ikke gir tilstrekkelig uttelling for egen tjeneste [14; se Vedlegg 4]. Selv om det finnes gode samarbeidsinitiativer, er de ofte personavhengige, midlertidig finansiert og uten tydelig forankring. Dette gjør dem sårbare for bortfall når ildsjeler slutter eller prosjektmidler fases ut [19]. Geografiske og økonomiske forskjeller mellom kommuner gjør det også vanskelig å overføre gode løsninger fra et sted til et annet.

4.4 Konsekvenser

Når barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, eller hjelpen ikke er tilpasset deres behov, kan det få alvorlige konsekvenser – ikke bare for dem selv, men også for deres pårørende, helsepersonell og samfunnet som helhet.

Barn og unge

Dersom psykiske helse- og rusmiddelutfordringer ikke fanges opp og hjelpen ikke gis tidlig nok, øker risikoen for at plagene forverres og blir langvarige. Opplevelsen av å ikke bli hørt eller forstått kan svekke tilliten til systemet og redusere effekten av hjelpen. Barn med sammensatte eller uavklarte utfordringer er særlig sårbare, og manglende samarbeid mellom tjenester kan føre til at de faller mellom stoler. Mangel på riktig hjelp til rett tid kan føre til skolefravall, svak tilknytning til arbeidslivet, tidlig uførhet og økt behov for sosialhjelp [25]. Dette kan føre til utenforskap, tap av mestringsfølelse og redusert livskvalitet. I ytterste konsekvens øker risikoen for selvskading

Pårørende og mindreårige søsken

Konsekvensene rammer også dem som står nærmest barna. Når hjelpen uteblir eller er fragmentert, må pårørende ofte ta ansvar for koordinering. Mindreårige søsken påvirkes også av at et familiemedlem har psykiske plager eller har rusmiddelproblemer [1]. Dette kan være svært belastende og dermed gi lavere livskvalitet og egne helseutfordringer, som stress, utbrenthet og i noen tilfeller fravall fra arbeidslivet.

Helsepersonell

Manglende tidlig innsats og koordinering kan føre til mer komplekse behandlingsbehov og økt press på spesialisthelsetjenesten. Manglende samarbeid og verktøy for informasjonsdeling gir dobbeltarbeid og dårlig ressursutnyttelse i en allerede presset helsetjeneste. Rammebetingelser som begrenser muligheten til å tilby helhetlig hjelp kan også føre til frustrasjon og lav tilfredshet i jobben. Mindre fagmiljøer gir utfordringer med kompetanseutvikling og kvalitet, og øker risikoen for fravall i helsepersonellgruppene [5, 6, 13].

Samfunn

Dersom barn og unge ikke får den hjelpen de trenger og utfordringene utvikler seg til mer alvorlige problemer, kan det føre til økte behandlingskostnader knyttet til lengre behandlingssløp eller mer sammensatte plager og behov for at flere instanser kobles på. I tillegg gir utenforskap, arbeidsledighet, tidlig uførhet, og i verste fall tidlig død, mer langsiktige samfunnskostnader. Disse forsterkes ytterligere dersom pårørende faller ut av arbeidslivet [4].

Kapittel 5

5. Samfunns- og effektmål

Dette kapittelet beskriver de målene man ønsker å nå ved å gjennomføre tiltak i helse- og omsorgstjenestene innen rus og psykisk helse for barn og unge. Målene har bakgrunn i de utfordringene som ble avdekket i innsiktsarbeidet, og er i tråd med de overordnede målene og strategiene for helse- og omsorgssektoren. Målene tar også innover seg mer generelle utfordringer i helse- og omsorgssektoren knyttet til mangel på personell og økende behov for helse- og omsorgstjenester i befolkningen.

Det er utarbeidet ett samfunnsmål og to effektmål. Samfunnsmålet reflekterer den ønskede tilstanden eller utviklingen på samfunnsnivå, mens effektmålene konkretiserer hvilke direkte effekter man ønsker å oppnå for barn og unge med psykiske helse- eller rusmiddelutfordringer og for helse- og omsorgstjenestene.

Samfunnsmål

Bedre helse og økt livskvalitet for barn og unge gjennom styrket brukerinvolvering og mer bærekraftige, integrerte helse- og omsorgstjenester innen rus og psykisk helse.

Effektmål

1. Bedre helse og økt livskvalitet for barn og unge med psykiske helse- eller rusmiddelutfordringer
2. Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene som følge av mer integrerte tjenester innen rus og psykisk helse

Kapittel 6

6. Relevante tiltak

Oppdragsteksten beskriver en integrert ungdomstjeneste på ett nivå. Utredningen har imidlertid ledet til flere ulike tiltaksalternativer med mål om å gi bedre helse og økt livskvalitet for barn og unge gjennom mer integrerte helse- og omsorgstjenester innen rus og psykisk helse. Prosessen for tiltaksutforming er beskrevet i vedlegg 3.

Arbeidet ledet frem til følgende fire tiltak som er tatt med videre til virkningsvurdering:

- A. Øke andelen rammefinansiering i psykisk helsevern for barn og unge og TSB for målgruppen (kap. 6.2)** Mer fleksibilitet til å tilpasse oppfølging etter barn og unges individuelle behov **B. Felles plan i helsefellesskapet (kap. 6.3)**

Forpliktende plan for psykisk helse- og rusmiddeltilbud til barn og unge

- C. Kommunalt avklaringsteam (kap. 6.4)**

Et team i kommunen, med representanter fra kommune og spesialisthelsetjeneste, som bidrar til at barn og unge får tilpasset hjelp på riktig nivå

- D. Avklarings- og inntaksteam forankret i helseforetaket (kap. 6.5)**

Et felles team på tvers av nivåer som bidrar til at barn og unge får tilpasset og riktig hjelp på riktig nivå.

Det skisseres to ulike teambaserte modeller (tiltaksalternativ C og D), som har ulik forankring, men samme formål og lignende innhold. Begge teammodellene er tatt med for å illustrere fordeler og ulemper med ulik organisatorisk ansvars plassering.

Enkelte av tiltaksalternativene er kombinert i en tiltakspakke, som også er virkningsvurdert:

- E. Felles plan i helsefellesskapet og en av teammodellene**

I tillegg til tiltaksalternativ A-E over, er også en videreføring av dagens situasjon uten å gjøre tiltak, altså nullalternativet, et reelt alternativ.

Mer detaljerte beskrivelser av de fire virkningsvurderte tiltaksalternativene finnes i vedlegg 5.

I tillegg til tiltaksforslagene som ble virkningsvurdert, var forslaget om en integrert helsetjeneste på ett nivå, som beskrevet i oppdragsteksten, et alternativ. Dette ble imidlertid parkert i samråd med HOD før virkningsvurderingene. En vurdering av dette forslaget finnes i kapittel 6.6, og en nærmere beskrivelse finnes i vedlegg 6.

6.1 Nullalternativet

Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon, og det er vedtatt politikk som skal ligge til grunn for nullalternativet. Nullalternativet brukes som sammenligningsgrunnlag for virkningene av tiltakene som utredes.

Det er utfordrende å få et fullstendig bilde av hva dagens situasjon er, blant annet når det gjelder hvilke tilbud de ulike kommunene har og hvilke samarbeidstiltak som eksisterer mellom kommuner og helseforetak rundt om i landet. Dette skyldes blant annet at hva som er et nødvendig og forsvarlig helsetilbud for denne gruppen til en viss grad er åpent for tolkning i kommunen, og at hver kommune selv styrer sitt eget helsetilbud. Dette fører til at det ikke er et standardisert begrep for tjenestene og at innholdet i tilbudet avhenger av ulike rammer, behov og prioriteringer i kommunene. Innsiktsarbeidet viser at det til en viss grad er liten kontinuitet i disse tilbudene - at det stadig er nye tilbud som kommer til og andre som forsvinner.

Som beskrevet i kapittel 2 og vedlegg 2, er det flere prosjekter og initiativer, både lokalt og nasjonalt, som kan ha betydning for videreutvikling av dagens situasjon, blant annet implementering av veileder i psykisk helsearbeid barn og unge, ulike teammodeller og satsingen på digital samhandling. Veileder i psykisk helsearbeid barn og unge tydeliggjør kommunens ansvar for å utvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge, og tar også for seg ansvar for samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Implementering av denne veilederen har et langsiktig mål om at tjenestetilbudet i kommunene blir styrket og at samarbeidet på tvers av nivåer øker i årene som kommer.

En av teammodellene som er prøvd ut er FACT ung, en tilpasning av FACT-modellen for målgruppen 12–25 år. Modellen er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Disse teamene jobber oppsøkende mot ungdom med psykiske helseplager og/eller rusmiddelproblemer med langvarige og sammensatte behov. Teamene består av ansatte fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og samarbeider med aktører som barnevern, skole, fastleger og NAV. Samarbeidet og det felles ansvaret reguleres gjennom samarbeidsavtaler som utvikles i hvert enkelt team og tilpasses lokale forhold. Foreløpige evalueringer viser lovende resultater, og satsingen støttes nasjonalt fra Helsedirektoratet og koordineres av NAPHA. Det er imidlertid avdekket utfordringer knyttet til organisering, ulik finansiering og manglende felles journalsystem, noe som gjør effektene usikre dersom disse utfordringene ikke løses.

Satsingen på digital samhandling gjennomføres i perioden frem til 2029. Tiltak i satsingen inkluderer blant annet pasientens journaldokumenter, som skal gi helsepersonell tilgang til journaldokumenter fra andre virksomheter. Helsepersonell trenger relevant, oppdatert og korrekt informasjon for å ta gode beslutninger om rask, god og trygg helsehjelp. Tilsvarende trenger barn, unge og pårørende tilgang til informasjon for å medvirke aktivt i valg om egen helse. Nasjonale samhandlingstjenester, som tiltakene i satsingen digital samhandling, søker å bidra til dette gjennom å tilgjengeliggjøre viktig helseinformasjon, på tvers av aktører, virksomheter og omsorgsnivå. Dette kan bidra til økt effektivitet, tilfredshet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Dette tilsier at man i tiden fremover kan forvente en viss forbedring i helsetilbudet og samarbeidet på tvers av nivåer, uten at det blir iverksatt ytterligere tiltak. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor stor effekten vil være, samt når den eventuelt vil inntreffe, og vi har derfor ikke lagt dette til grunn i nullalternativet. Det er imidlertid viktig å være klar over at effekten av tiltakene i denne utredningen vil kunne være mindre enn det vi har anslått dersom disse andre prosjektene eller initiativene fører til et forbedret helsetilbud eller mer samarbeid på tvers.

6.2 Økt andel rammefinansiering i PHBU og TSB

Hva går tiltaket ut på?

Det foreslås å øke andelen rammefinansiering i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for målgruppen. Dette kan muliggjøre mer fleksibel og individuelt tilpasset oppfølging og behandling, samt styrke samarbeidet på tvers av nivåer. I dag utgjør rammefinansieringen rundt 75 prosent og ISF utgjør omtrent 25 prosent. Samtidig er det uklart om en økning av rammefinansieringen vil føre til mer eller mindre midler til denne delen av spesialisthelsetjenesten, og også om det vil føre til en endret klinisk praksis eller ikke.

Tiltaket kan gjøres enten ved:

- Redusert andel innsatsstyrt finansiering (ISF) innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB for målgruppen. Det vil si å redusere andelen av gjennomsnittskostnadene det utbetales refusjon for.
- Fjerne ISF innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB for målgruppen

Hva må gjøres?

Stortingsbehandling

En endring av ISF-andelen må avgjøres politisk. Deretter vil det kun være mindre endringer i systemer og kommunikasjon som behøves for å formidle endringen. Denne endringen vil ikke være så stor at det vil være behov for ekstra personell.

Tidsramme

En større andel rammefinansiering er en endring som må foreslås av regjeringen og behandles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Endringen kan deretter ha virkningstidspunkt fra og med 1. januar i det påfølgende år.

Hvordan skal tiltaket finansieres?

Tiltaket behøver ikke ekstra finansiering. En endring av andelen rammefinansiering har lave administrative kostnader. Administrative oppgaver i sykehusene knyttet til en endring, bør kunne inngå som en del av de vanlige arbeidsoppgavene til ansatte som jobber med dette.

Hvilke problemer løser tiltaket og hva oppnår vi?

Tiltaket baserer seg på en antakelse om at dagens ISF-andel i for stor grad påvirker hvilken aktivitet som utføres. Antakelsen er blant annet basert på tilbakemeldinger i innsiktsfasen fra representanter fra spesialisthelsetjenesten. Det antas videre at dette kan gå på bekostning av mer individuelt tilpassede helsetjenester og samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge og TSB har ofte komplekse og sammensatte lidelser. Pasienter med samme lidelser kan ha behov for ulik behandling, både i type, intensitet og omfang. Dette kan være lite forenlig med et system med aktivitetsavhengige refusjoner. Ved å øke andelen rammefinansiering kan helseforetakene i større grad kan fokusere mer på individuelt tilpasset behandling og samhandling med øvrige forvaltningsnivåer. Det er imidlertid betydelig usikkerhet rundt de samlede effektene av tiltaket, både på grunn av flere effekter som trekker i ulik retning og uklare årsakssammenhenger. Dette er beskrevet i virkningsanalysen i kapittel 7.

6.3 Felles plan i helsefelleskap

Hva går tiltaket ut på?

Helseforetaket og kommunene i et helsefellesskap utarbeider en samlet, felles og forpliktende plan for psykisk helse- og rustilbudet til barn og unge i kommunene og helseforetaket. Denne planen vil kunne si noe om et minstenivå av tjenester som kommunene skal etablere og opprettholde. Tiltaket samsvarer med trinn 4 i integreringsstigen.

Planen kan eksempelvis inneholde:

- Enighet om hvilket tilbud kommunene skal ha for målgruppen
- Kriterier for når barn og unge bør henvises til spesialisthelsetjenesten
- Rutiner for kommunal oppfølging under og etter endt behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten
- Enighet om interkommunale samarbeid om tjenester, f.eks. deling av personell og felles tjenester

Hva må gjøres?**Plan og ansvar**

Planens innhold må forhandles mellom kommunene og helseforetaket. Helsedirektoratet kan ved behov gi veiledning om gjennomføring av planarbeidet og aktuelle problemstillinger det kan være nyttig å ha med i planen. Ansvaret for å utarbeide planen kan ligge til henholdsvis kommunene og de regionale helseforetakene. For kommunene vil kommunestyret måtte vedta planen. For kommunene kan det være aktuelt å involvere flere organisatoriske enheter, avhengig av hvordan ansvar for psykisk helse og rusarbeid for barn og unge er organisert.

Vurdering av behov for regelverksendringer

Det er ikke behov for regelverksendringer for å starte planarbeidet. På sikt kan det vurderes om deltakelse i helsefellesskapene og plikt til å utarbeide planer gjennom helsefellesskapet bør lovfestes. Dette kan vurderes etter at tiltaket er prøvd ut.

Tidsramme

Tiltaket må først forankres i kommunesektoren og hos de regionale helseforetakene. I første omgang kan det gis føringer i styringslinjen til de regionale helseforetakene og planarbeidet kan forankres i regjeringens samarbeid med KS. Det bør settes av cirka to år til planlegging, forankring og utarbeidelse av plan før tiltaket kan tre i kraft.

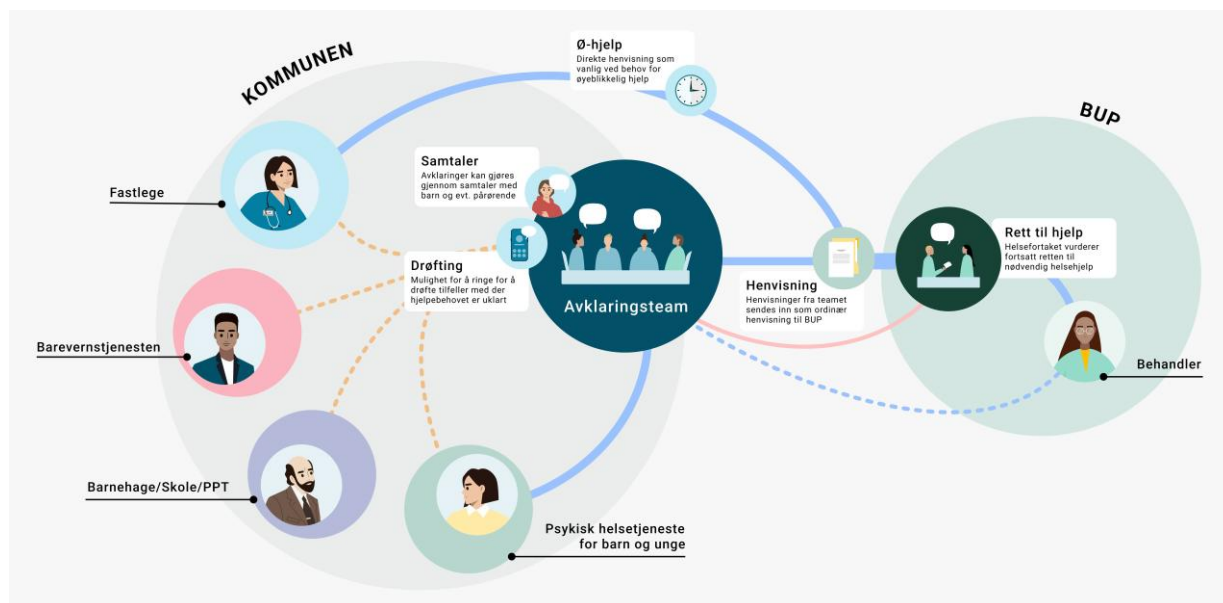
Hvordan skal tiltaket finansieres?

Arbeidet med en felles plan vil medføre noe økt administrasjon, herunder mer møtevirksomhet og flere forankringsprosesser. Dette vil i størst grad gjelde i det året planen skal fremforhandles og vedtas første gang. For å stimulere til planarbeidet, bør det vurderes å gi tilskuddsmidler til helsefellesskapene. Videre bør kommuner som ønsker å bygge opp et bedre psykisk helse- og rustilbud til barn og unge få mulighet til å søke om tilskuddsmidler.

Hvilke problemer løser tiltaket og hva oppnår vi?

En felles plan vil bidra til felles prioriteringer av tilbud og tjenester og felles forståelse av ansvar og handlingsrom. Planarbeidet kan løfte tilbudet i kommuner der tjenestetilbudet ikke er godt etablert, ved å synliggjøre ulikheter og behov. Planen kan åpne for mer interkommunalt samarbeid som kan bidra til bedre ressursutnyttelse.

6.4 Avklaringsteam i kommunen



Hva går tiltaket ut på?

Et avklaringsteam etablert i kommunen skal, i tett samarbeid med helseforetaket, vurdere og avklare om barnet eller ungdommen bør få helsehjelp i kommunen eller henvises til spesialisthelsetjenesten. Teamet bistår helsepersonell som fastlege og helsesykepleier eller andre kommunale tjenester dersom de er i tvil om hvilket (helse)tilbud barnet eller ungdommen har behov for. Dette kan gjøres gjennom felles møter eller felles samtaler med barnet eller ungdommen og evt. foreldre. Tiltaket samsvarer med trinn 4 i integreringsstigen.

Teamet kan ha fast telefontid og ta imot henvendelser fra helsepersonell eller andre aktører som barnehage/skole/PPT eller barnevern eller andre helsetjenester og tilby veiledning eller avklaringssamtaler med barn og unge for å avklare videre helsebehov eller kortvarig oppfølging. Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller ved mistanke om psykiske lidelser skal henvendelsen gå direkte til BUP.

Ved mistanke om en psykisk lidelse eller bekymring for rusmiddelproblemer, kan barnets fastlege eller avklaringsteamet (ved lege eller psykolog) henvise barnet til spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket vil vurdere om barnet eller ungdommen har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter reglene i pbrl. § 2-2 og § 22a. Teamet følger opp barnet eller ungdommen til henvisningen er vurdert. Dersom barnet eller ungdommen ikke får rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, bør teamet bistå med å finne egnet kommunalt tilbud. Teamet følger opp til nytt tilbud er etablert eller behovet opphører. Ved overføring eller henvisning til en ny tjeneste, bør teamet bistå med informasjonsdeling ved behov.

Hva må gjøres?

Organisering

Kommunene oppretter avklaringsteam, alene eller i interkommunalt samarbeid, der representanter fra helseforetaket også deltar. Det kan være hensiktsmessig at teamet har med en koordinator som planlegger og koordinerer møter og annet arbeid.

Avklaringsteamet bør være tverrfaglig og bør minimum bestå av to kommunale representanter med helse- og sosialfaglig kompetanse, eventuelt med videreutdanning, og psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, eventuelt barne- og ungdomspsykiater fra spesialisthelsetjenesten. Ettersom teamet skal vurdere mulige henvisninger til BUP, bør det være spesialistkompetanse fra helseforetaket med god kjennskap til spesialisthelsetjenestens tilbud og vurdering av henvisninger. Det kan også være fastlege representert i teamet. Ved behov for henvisning til spesialisthelsetjeneste, kan dette ev. ivaretas av fastlege i teamet eller i samarbeid med barnets eller ungdommens fastlege. Det kan også være aktuelt med representanter fra andre relevante sektorer fra kommunen. Teamets deltakere bør ha bredde- og mengdekompetanse til å vurdere ulike

tilstandsbilder og alvorlighets-grader og kjenne tilbudene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Et kommunalt avklaringsteam kan ha ulik størrelse og sammensetning. Teamets funksjoner og oppgaver bør tilpasses lokale forhold.

Behov for regelverksendringer

I utgangspunktet står kommunene fritt til å organisere tjenestetilbudet sitt etter lokale forhold og slik kommunen finner det hensiktsmessig. Dersom kommunene skal pålegges en bestemt organisering av tjenestetilbudet sitt, må dette forankres i lov, jf. kommuneloven § 2-1 tredje ledd. En implementering av tiltaket som sikrer kommunalt forankrede avklaringsteam for alle kommuner vil dermed kreve at det lovfestes en plikt i helse- og omsorgstjenesteloven som pålegger kommunene å ha slike team. En slik bestemmelse kan eventuelt tas inn i lovens kapittel 3. Hvorvidt det er nødvendig å bruke lovfesting som virkemiddel bør vurderes etter en utprøving av tiltaket. I en utprøving vil det ikke være behov for regelverksendringer, da deltakelse vil være frivillig for kommunene, og kommuner står fritt etter dagens regelverk til å velge å organisere tjenestene sine ved å opprette avklaringsteam.

Tidsramme

Dersom det vurderes at det er ønskelig med lovendringer for å implementere tiltaket i alle landets kommuner, bør det normalt settes av cirka to år før lovendringer er på plass. Noen kommuner og helseforetak har i dag lignende teamstrukturer som det vil være naturlig å bygge videre på, slik at tiltaket kan iverksettes relativt raskt etter en eventuell lovendring. Det sentrale med dette tiltaket er imidlertid samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene, og dette samarbeidet må etableres der det ikke allerede er etablert. Det bør derfor settes av noe tid til organisering og planlegging før tiltaket kan realiseres.

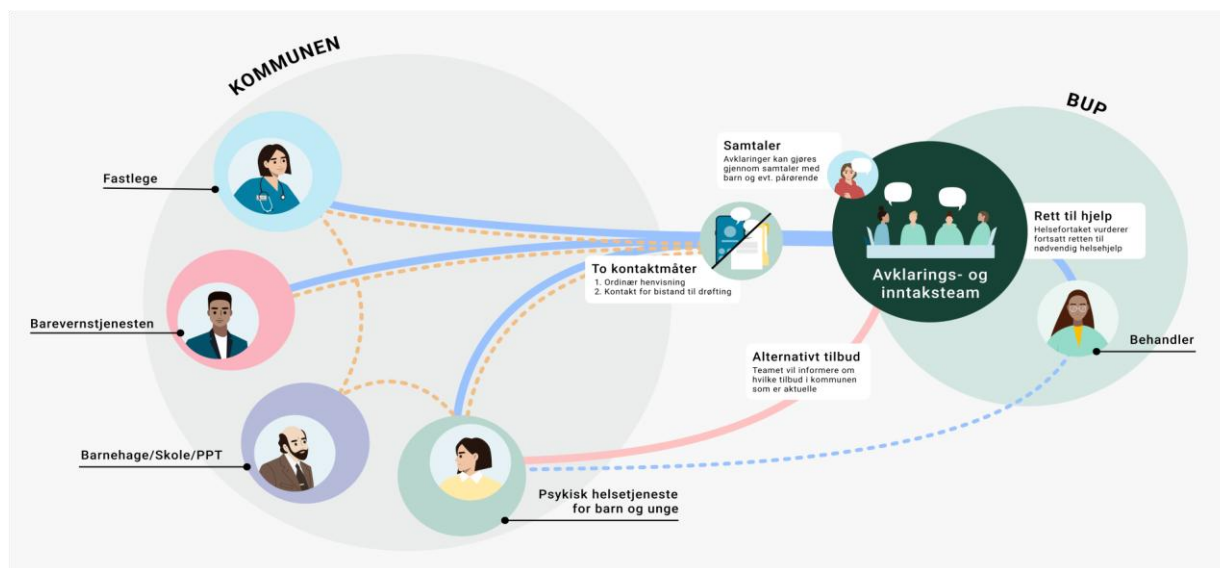
Hvordan skal tiltaket finansieres?

Dersom tiltaket implementeres med en plikt for kommunene til å ha avklaringsteam, vil dette kreve ytterligere finansiering til kommunene. For å legge til rette for en bærekraftig og robust modell bør det også legges til rette for en tilskuddsordning som gjør det enklere for kommunene å delta i et slikt samarbeid. Tilskuddsordningen bør være over flere år og inneholde krav om at kommunene øker graden av egenfinansiering i løpet av tilskuddsperioden. Tiltaket medfører noen økte kostnader for spesialisthelsetjenesten som følge av at de må bidra inn i avklaringsteamet. Det kan vurderes om dette tilsier at spesialisthelsetjenestens rammetilskudd bør økes noe, men det anses sannsynlig at dette er noe spesialisthelsetjenesten bør kunne gjennomføre uten en økning i rammetilskuddet. Dette kan da gå på bekostning av noen andre arbeidsoppgaver i spesialisthelsetjenesten.

Hvilke problemer løser tiltaket og hva oppnår vi?

Barn og unge opplever ofte å bli kasteballer mellom ulike tjenester. Dette tiltaket skal bidra til at de får én tydelig vei inn til den hjelpen de trenger. Samarbeid om felles avklaringer og eventuelt felles samtaler med barnet eller ungdommen kan bidra til riktigere hjelp på rett sted med barn og unges individuelle behov som utgangspunkt. En felles avklaring av barnets eller ungdommens behov tydeliggjør et felles ansvar for barnet eller ungdommen. Begge tjenestene får mer og bedre kunnskap om hverandre og bidrar til gjensidig kompetanseheving, bedre ressursutnyttelse og en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling i ulike deler av et pasientforløp.

6.5 Avklarings- og inntaksteam forankret i helseforetaket



Hva går tiltaket ut på?

Samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket styrkes ved at det etableres et avklarings- og inntaksteam som vurderer om barn og unge bør få helsehjelp i kommunen eller spesialisthelsetjenesten når henvisere er usikre på hvilket tilbud som er mest egnet. Teamet vurderer henvisninger og henvendelser, og gjennomfører avklaringssamtaler ved behov. Samtalene gjennomføres av representanter fra både spesialisthelsetjenesten og kommunene, med formål om å tydeliggjøre barnets eller ungdommens behov og informere om hvilke tilbud som er aktuelle. Tiltaket samsvarer med trinn 4 i integreringsstigen.

Teamet kan få kontakt med barn og unge på ulike måter:

- Det sendes en ordinær henvisning til BUP, fra fastlegen, psykolog eller leder i barnevernstjenesten mv. Alle henvisninger som sendes til BUP vil komme til avklarings- og inntaksteamet.
- Fastlegen/barnevernstjeneste/psykolog tar kontakt med teamet for å få bistand til å avklare barnets eller ungdommens behov for helsehjelp.

Uavhengig av om teamet får kontakt med barnet eller ungdommen gjennom henvisning eller annen henvendelse, anses kontakten med teamet som en henvisning til spesialisthelsetjenesten etter pbrl. § 2-2. Andre tjenester som ønsker å ta kontakt med teamet må som hovedregel henvende seg til fastlege eller psykolog i kommunen før de tar kontakt med teamet for å sikre at kommunale tjenester vurderes før man kobler på avklarings- og inntaksteamet.

Hva må gjøres?

Organisering

Helseforetaket oppretter avklarings- og inntaksteam med deltakelse fra alle eller et utvalg av kommuner i helseforetakets opptaksområde. Det kan være hensiktsmessig at teamet har med en koordinator som planlegger og koordinerer møter og annet arbeid.

Kompetanse og funksjon

Avklarings- og inntaksteamet bør være tverrfaglig og minimum bestå av helse- og sosialfagligpersonell, eventuelt med videreutdanning, og psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, eventuelt barne- og ungdomspsykiater fra spesialisthelsetjenesten. Ettersom teamet skal vurdere henvisninger til BUP, er det nødvendig med spesialistkompetanse fra

helseforetaket. Teamets deltakere bør ha bredde- og mengdekompetanse til å vurdere ulike tilstandsbilder og alvorlighetsgrader og kjenne tilbudene i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Størrelsen på teamet kan variere. Det bør være minimum ett team tilknyttet hver poliklinikk i psykisk helsevern (BUP), som samarbeider med de/n kommunen/e eller bydelen/e de har ansvar for. For BUP-er som dekker mange kommuner, bør det være flere representanter fra kommunene i teamet. For å unngå for store team, bør kommunene inngå avtaler om representasjon av hverandre og ev. rullering av oppgaver. BUP bør være representert med to personer i hvert team. Teamet møtes minimum 1 gang per uke for å vurdere henvisninger/henvendelser, men bør også ha en beredskap for å håndtere henvendelser som haster mer. Øyeblikkelig hjelp-henvendelser skal fortsatt gå direkte til BUP. Teamets funksjoner og oppgaver kan tilpasses lokale forhold. Men det bør settes av tid, også utover å vurdere henvendelser/henvisninger, bl.a. til avklaringsamtaler slik at disse kan gjennomføres i løpet av kort tid ved behov.

Behov for endringer i regelverk

Tiltaket innebærer at det gjøres endringer i pasient- og brukerrettighetsloven slik at det kan gjennomføres en avklaringsamtale før helseforetaket vurderer om barnet eller ungdommen har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Endringen gjennomføres uten at gjeldende frister for vurdering av henvisning eller oppstart av helsehjelp endres. Lovendringen beskrives nærmere i vedlegg 5. Ved en eventuell utprøving av tiltaket, vil forsøksloven gi hjemmel for å gjøre unntak fra dagens regelverk i forsøksperioden, jf. forsøksloven § 3.

Tidsramme

Det er behov for lovendringer for å innføre tiltaket og det må utarbeides forskrifter tilknyttet lovendringene. Det bør normalt settes av cirka to år før lovendringer er på plass.

Det finnes i dag modeller i flere RHF-er som det vil være naturlig å bygge videre på, slik at tiltaket kan iverksettes relativt raskt etter en lovendring. Det sentrale med dette tiltaket er imidlertid samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene, og dette samarbeidet må etableres der det ikke allerede er etablert. Det bør derfor settes av noe tid til organisering og planlegging før tiltaket kan realiseres, men mye av dette arbeidet kan gjøres i påvente av at lovendringer skal vedtas og tre i kraft. Det legges derfor til grunn at tiltaket kan iverksettes om cirka to år.

Hvordan skal tiltaket finansieres?

For helseforetakets del, kan de organisatoriske endringene i hovedsak gjennomføres uten tilføring av ressurser. For kommunene kan deltakelse i et slikt team anses som en ny oppgave som vil kreve ytterligere finansiering til kommunene. For å legge til rette for en bærekraftig og robust modell bør det også legges til rette for en tilskuddsordning som gjør det enklere for kommunene å delta i et slikt samarbeid. Tilskuddsordningen bør være over flere år og inneholde krav om at kommunene øker graden av egenfinansiering i løpet av tilskuddsperioden.

Hvilke problemer løser tiltaket og hva oppnår vi?

Barn og unge opplever ofte å bli kasteballer mellom ulike tjenester. Dette tiltaket skal bidra til at de får én tydelig vei inn til den hjelpen de trenger. Samarbeid om felles avklaringer og eventuelt felles samtaler med barnet eller ungdommen kan bidra til riktiger hjelp på rett sted med barn og unges individuelle behov som utgangspunkt. En felles avklaring av barn og unges behov tydeliggjør et felles ansvar for barnet eller ungdommen. Begge tjenestene får mer og bedre kunnskap om hverandre og bidrar til gjensidig kompetanseheving, bedre ressursutnyttelse og en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling i ulike deler av et pasientforløp.

6.6 Integrert helsetjeneste – En felles helsetjeneste på ett nivå

Innsiktsarbeidet ga grunnlag for å utvikle et tiltaksalternativ som ble kalt "En felles helsetjeneste på ett nivå". Det ble utarbeidet en overordnet beskrivelse av hva et slikt alternativ ville innebære, se vedlegg 6. Beskrivelsen samsvarer i stor grad med det øverste trinnet på integreringsstigen som innebærer en fullt integrert helsetjeneste og et sammenslått tjenestenivå.

Det ble vurdert som utfordrende å avgrense en integrert helsetjeneste på ett nivå til kun barn og unge med psykiske helse- og rusmiddelutfordringer. Vurderingen bygget på at det ville være store utfordringer med å organisere tjenester for denne målgruppen uavhengig av øvrige kommunale psykisk helse- og rustjenester, samt somatiske helsetjenester og habilitering i spesialisthelsetjenesten. Avhengig av hvordan tjenestetilbudet er organisert i kommunen og spesialisthelsetjenesten lokalt, kan det være tilfeldig om denne målgruppen får tilbudet sitt i psykisk helse- eller rustjeneste, habilitering eller somatikk.

Videre ble det innhentet innspill til dette alternativet, men basert på tilbakemeldingene ble det vurdert at tiltaket måtte detaljeres for at det skulle være mulig å gi konkrete vurderinger av potensielle virkninger av tiltaket. Helsedirektoratet fikk i en tidlig fase en orientering om arbeidet med en helsetjeneste på ett nivå i Finland. Denne orienteringen gjorde det tydelig at det var mange forhold som ville tatt tid å avklare. Det ville derfor være behov for å ta mange forbehold i en slik detaljering, noe som igjen ville medført utfordringer med å gi tilbakemeldinger på mulige virkninger.

En grov beskrivelse av tiltaket viste imidlertid at det ville innebære omfattende endringer og betydelige omstillingskostnader. Parallelt med disse vurderingene ble Helsereformutvalget opprettet. Slik vi leste deres mandat, var det overlappende med det arbeidet vi vurderte var nødvendig for en virkningsvurdering av alternativet.

I samråd med Helse- og omsorgsdepartementet ble tiltaket derfor parkert, men med en mulighet for å utrede det videre på et senere tidspunkt.

Det kan også vurderes andre alternativer for integrering som ikke er så omfattende som "En felles helsetjeneste på ett nivå". Andre alternativer kan inkludere delte stillinger og felles lokaler mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, hvor man integrerer tjenestene på en helt annen måte enn om BUP og kommuner arbeider hver for seg. Dette vil kunne underbygge tiltaksalternativene som er beskrevet i rapporten, og hvor det også kan være aktuelt med felles avklaringssteam for både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Det kan også vurderes om spesialisthelsetjenesten kan ta et større ansvar for pasientgruppen og at kommunen legger inn sine ressurser slik at spesialisthelsetjenesten kan ta et mer helhetlig ansvar. Ved pilotering vil det i så fall være aktuelt å gjøre unntak fra gjeldende regelverk med hjemmel i forsøksloven. Dette er heller ikke forhold som er utredet videre, da enkelte av pilotene i Prosjekt X vil dekke slike alternativer. Helsedirektoratet vil som angitt følge med på pilotene i prosjekt X og oppsummere erfaringer og læringspunkter.

6.7 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

Barnets beste

Utredningen omhandler tiltak rettet mot barn og unge. Det er derfor viktig å vurdere tiltakene opp mot hva som vil være barnets beste. Det følger av Grunnloven § 104 andre ledd at "Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn". Prinsippet stammer fra FNs barnekonvensjon artikkel 3. FNs barnekomité har uttalt at når vedtak påvirker barn, må beslutningsprosessen inkludere en vurdering av mulige konsekvenser av avgjørelsen for barnet eller barna det gjelder.

For våre tiltak er det særlig barnets synspunkter og barnets rett til helse som er relevante momenter å vurdere.

Innsiktsarbeidet har gitt oss innblikk i hva barn og unge selv mener er viktig med et tjenestetilbud, og dette har ligget til grunn for utformingen av tiltakene. Innsikten har vist at barn og unge er særlig opptatte av at hjelpen er lett tilgjengelig, at informasjon finnes der de er, som på sosiale medier og skolen, og at de får mulighet til å medvirke i egen behandling. I vurderingen av tiltakenes virkninger, har vi vektlagt hvordan tiltakene antas å påvirke barn og unges livskvalitet og helse (nyttevurderingene).

Det kommunale selvstyret

Et viktig hensyn som må vurderes for tiltak som retter seg mot kommunene er hvordan tiltaket forholder seg til det kommunale selvstyret. Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet i Grunnloven § 49 andre ledd, som sier at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Prinsippet kommer også frem i kommuneloven § 2-1 og § 2-2, som blant annet sier at begrensninger i det kommunale selvstyret må ha hjemmel i lov og at det kommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

I utredningen har vi veid hensynet til det kommunale selvstyret mot behovet for et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrenser. Innsiktsarbeidet har vist at det er behov for noe nasjonal styring av kommunene for å sikre et likeverdig og godt nok tilbud av psykisk helse- og rustjenester til barn og unge. Ved utformingen av tiltakene som berører kommunene, har vi lagt vekt på at kommunene skal ha mulighet til å innrette tilbudet etter lokale forhold og benytte eksisterende løsninger der dette er mulig og hensiktsmessig. For de tiltakene der det er et alternativ å bruke lov- og forskriftsregulering for å sikre likhet i tilbudet i kommunene, har vi vurdert at bruken av slike virkemidler må vurderes etter en eventuell utprøving og evaluering av tiltakene.

Helsepersonellkonsekvenser

Mangel på personell er den største utfordringen helse- og omsorgstjenesten står overfor fremover⁵. Et viktig spørsmål i utredninger som innebærer tjenesteutvikling er derfor å vurdere hvordan tiltakene påvirker ressursituasjonen, og særlig behovet for helsepersonell. Tiltakene som er utarbeidet i prosjektet anses ikke å kreve stor grad av nye ressurser. Tiltaket som foreslår å øke andelen rammefinansiering i PHBU og TSB for målgruppen kan anses å være noe personellbesparende for helsepersonell og i helseforvaltningen, ved at man bruker mindre tid på ISF-rapportering. I de to teammodellene legger vi til grunn at det i stor grad kan brukes eksisterende ressurser og bygges videre på eksisterende modeller for samarbeid. Det må imidlertid påregnes noe økt bruk av helse- og/eller sosialfaglig personell. Tiltaket som omhandler å lage en felles plan for tjenestetilbudet vil innebære noe økning i personellbruk, men først og fremst av administrativ art. Tiltaket anses ikke å kreve økt bruk av helsepersonell. Det vises for øvrig til vurderingene av tiltakenes virkninger i kapittel 7.

Kapittel 7

7. Virkningsanalyse

Virkningsanalysen er gjennomført i tråd med gjeldende veiledere på området, herunder Finansdepartementets rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser fra 2021 og DFØs Veileder i samfunnsøkonomisk analyse fra 2023 [27]. Virkningene er prissatt så langt det har latt seg gjøre. De ikke-prissatte virkningene er vurdert ved hjelp av verdimatrisemetoden [28].

Kostnader og nytte er regnet i 2025-kroner. Analyseperioden er 10 år og diskontering tar utgangspunkt i tiltakenes oppstartsår som er satt til 2029. Når tiltak skal finansieres over offentlige budsjetter, skal man i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 inkludere en skattefinansieringskostnad i analysen, og denne er satt til 20 øre per krone. I analysen er det forutsatt at det gjennomføres pilotering av anbefalt tiltak og at denne følgeevalueres i perioden 2026-2028. I analysen er det tatt hensyn til at noen helseforetak og kommuner har eksisterende samarbeid som ligner på tiltaksalternativene vi utreder, og tiltaksvirkningene er justert deretter.

Dette er en tidligfaseutredning, med en forholdsvis overordnet vurdering av konseptuelt forskjellige tiltaksalternativ. Dette reflekteres i betydelig usikkerhet i forutsetninger som er lagt til grunn i analysen og i den påfølgende verdsettingen av kostnader og nytte. Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse og dekningsanalyse for å belyse usikkerheten.

7.1 Identifiserte berørte aktører og virkninger

Det er lagt til grunn følgende grupper blir vesentlig berørt av tiltakene:

- Barn og unge med psykiske helse- og/eller rusmiddelutfordringer
- Deres pårørende
- Helsepersonell i kommunale helsetjenester innen psykisk helse og rus
- Helsepersonell i psykisk helsevern for barn og unge og TSB
- Kommuner
- Helseforetak

I tillegg vil fastleger og annet merkantilt personell i spesialisthelsetjenesten til en viss grad påvirkes av tiltakene. Forvaltningen, herunder Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, og samfunnet for øvrig vil også påvirkes i mindre grad.

Tabellen under oppsummerer de identifiserte nytte- og kostnadsvirkningene for de ulike tiltakene A-D. En prikk indikerer at tiltaket vil kunne ha virkning. Grønn indikerer at virkningen er positiv (nyttevirkning), rød indikerer at virkningen er negativ (kostnadsvirkning) og grå indikerer at effekten er usikker. Tiltakskombinasjonen E er ikke vist i tabellen, men virkninger fra enkelttiltak vil oppstå også når de inngår i kombinasjon.

Virkninger er vurdert basert på innhentede innspill fra brukere, helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten, statistikk, eksisterende forskning og annen kunnskap.

Tabell 7-1: Identifiserte nytte- og kostnadsvirkninger per tiltak

	A. Øke andel rammefinansiering	B. Felles plan i helsefelleskapene	C. Avklaringsteam i kommunen	D. Avklarings- og inntaksteam i helseforetaket
NYTTEVIRKNINGER				
Bedre helse for barn/unge og deres pårørende	●	●	●	●
Økt jobbtilfredshet	●	●	●	●
Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten	●	●	●	
KOSTNADSVIRKNINGER				
Økte kostnader i spesialisthelsetjenesten		●	●	●
Økte kostnader i kommunene		●	●	●
Dårligere data fra rapportering	●			

**Bedre helse og livskvalitet for barn/unge og pårørende**

Tiltak B-D vil kunne bidra til bedre helse og livskvalitet for barn/unge og pårørende. For eksempel vil bedre samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten kunne bidra til raskere avklaring av saker, raskere hjelp og at flere fanges opp. Det vil i så fall ha nytte for pasientene og deres pårørende.

Endelig effekt på barn/unges og deres pårørendes helse er mer usikker for tiltak A, der man øker andelen rammefinansiering i psykisk helsevern for barn og unge og TSB. I henhold til helsepersonell vi har snakket med som jobber i tjenestene, vil økt andel rammefinansiering og tilsvarende redusert andel ISF-finansiering, eller fjerning av ISF-finansiering, kunne gi økt prioritering av kvalitet og fag fremfor kvantitet/ inntektsbringende aktivitet, samt bedre prioritering etter medisinsk behov. Det vil også kunne gi økt prioritering av samarbeid og tverrfaglig arbeid. Dette vil kunne gi bedre oppfølging og behandling av barn og unge med psykiske helse- og/eller rusmiddelutfordringer, og dermed bedre helse for barna og ungdommene, men også deres pårørende. Dersom økt andel rammefinansiering gir økt prioritering av kvalitet, fag og samarbeid, på bekostning av kvantitet, kan det imidlertid gi lavere effektivitet, slik at færre barn og unge får behandling eller at ventetiden blir lengre. Dette vil kunne være negativt for helsen til de barna og ungdommene som ikke får behandling eller som må vente lengre før de får behandling. I en gjennomgang av forskningen som er gjort på bruk av ISF i Norge og sammenlignbare land fra 2022, konkluderes det med at det ikke er mulig å trekke entydige konklusjoner om ISF fører til endring i kvaliteten i pasientbehandlingen [29].

Videre er det slik at samarbeidsmøter med aktører utenfor spesialisthelsetjenesten i dag utløser ISF-refusjon. Dersom andel ISF-finansiering reduseres eller fjernes, er det en risiko for at slikt samarbeid i større grad nedprioriteres dersom ikke andre tiltak iverksettes for å stimulere til slikt samarbeid. En annen potensiell risiko uten øvrige tiltak, er at finansiering og budsjett i mindre grad vil følge behov og aktivitet, noe som kan gjøre det vanskeligere å bemanne opp ved behov. Dette vil kunne påvirke kvaliteten på tjenestene i negativ retning. Det er i tillegg en risiko for at dette tiltaket vil føre til at sykehusene i større grad prioriterer somatikk over psykisk helsevern. Dette skyldes at tiltaket innebærer å øke andelen rammefinansiering kun for psykisk helsevern for barn og unge og TSB, noe som gjør at mer aktivitet innen somatikk vil kunne medføre større ISF-refusjon og mer penger til sykehusene. Igjen vil dette kunne medføre lavere kvalitet på tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB. Det kan være ytterligere utilsiktede konsekvenser ved å øke andelen rammefinansiering, i tillegg til de virkningene som er beskrevet over.

Økt jobbtilfredshet

Økt samarbeid mellom tjenestenivåene forventes å gi bedre arbeidsmiljø og økt trivsel hos helsepersonell. For tiltaket som gjelder økt andel rammefinansiering, er det forventet at mindre press på gjennomføring av visse aktiviteter og noe mindre krav til rapportering knyttet til ISF og administrasjon vil føre til økt trivsel.

Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten

Vi legger til grunn at tiltaket som gjelder økt andel rammefinansiering (tiltak A) vil føre til noe mindre krav til rapportering knyttet til ISF, og at dette vil kunne frigjøre noe tid i spesialisthelsetjenesten. Den frigjorte tiden til registrering er knyttet til prosedyrekoder som helt eller delvis er opprettet for ISF formål, og ikke til aktivitetsbasert registrering som vi legger til grunn at helsepersonell uansett må gjennomføre. Det er også antatt at helseforetakene vil bruke mindre tid på å kvalitetssikre koding av aktivitet ved en reduksjon av ISF-andel, og at effekten er større jo mindre finansiering som er knyttet til aktivitet.

For de øvrige tiltakene er det forventet at økt samarbeid vil føre til bedre kvalitet på henvisningene til spesialisthelsetjenesten, noe som frigjør tid som tidligere ble brukt til å vurdere henvisninger.

Økte kostnader i helseforetakene

For tiltaket som gjelder felles plan i helsefellesskapene vil det måtte brukes en del tid på å utarbeide planen. For de to teammodellene, består kostnadene i hovedsak av tid brukt på å delta i møter.

Økte kostnader i kommunen

For tiltaket felles plan i helsefellesskapene vil det måtte brukes en del tid på å utarbeide planen. For de to tiltakene som gjelder team, består kostnadene av tid brukt på å delta i møter, og at kommunene tar imot flere pasienter.

Dårligere data fra rapportering

Tiltaket som gjelder økt andel rammefinansiering vil kunne medføre at kvaliteten på dataene som rapporteres blir dårligere. Når finansiering ikke er knyttet til aktivitet, er det imidlertid mulig at helsepersonell, HF-er eller RHF-er ikke er like nøye med registreringer, og at dette dermed påvirker kvaliteten på rapporteringen.

Økte kostnader i forvaltningen

Tiltakene innebærer noe tidsbruk i Helsedirektoratet knyttet til endringer i systemer og kommunikasjon ut mot kommuner og helseforetak. Tiltak D innebærer en lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven som vil medføre ressursbruk i forvaltningen ifm. lovendringsarbeidet. Disse kostnadene er ikke inkludert som en virkning videre i virkningsanalysen. En pilotering av anbefalt tiltak vil videre kreve oppfølging fra Helsedirektoratet, både knyttet til gjennomføring og evaluering av piloten(e). Pilotering av tiltaket avklarings- og inntaksteam i helseforetaket vil kreve at det gjøres midlertidige regelverksendringer med hjemmel i forsøksloven, som vil kreve arbeid fra relevante departementer. Kostnaden for Helsedirektoratet knyttet til pilotering og evaluering er inkludert som en prissatt virkning, mens kostnad knyttet til midlertidige regelverksendringer ikke er det fordi den er vanskeligere å anslå på nåværende tidspunkt.

7.2 Verdsetting av virkninger

A. Øke andelen rammefinansiering i psykisk helsevern og TSB for barn og unge

Vurdering av prissatte virkninger • Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten

Basert på intervjuer med helsepersonell legger vi til grunn at en fjerning av ISF, ev. en vesentlig reduksjon i andelen ISF, kan spare noe tid knyttet til rapportering. Vi har tatt utgangspunkt i registrerte prosedyrekoder i 2024 som kan knyttes til ISF-formål. Vi har antatt at et fåtall av kodene ville forsvunnet dersom ISF-finansieringen bortfaller, mens flertallet av kodene er medisinske koder som skal rapporteres til Norsk pasientregister uavhengig av ISF. Vi legger til grunn at et bortfall eller en vesentlig lavere ISF-andel, ville medført mest frigjort tid på kodene som er knyttet til ISF-formål, men at man også frigjør noe tid på de som ikke forsvinner, fordi man sannsynligvis vil bruke mindre tid på å vurdere om aktiviteten oppfyller ISF-kriterier når disse i mindre grad er knyttet til finansiering. Dette tilsvarer en verdi på **mellom 2 og 7 mill. kroner** årlig ved en vesentlig reduksjon eller fjerning av ISF. Dette utgjør **mellom 18 og 55 mill. kroner** over analyseperioden. Merk at anslaget er beheftet med stor usikkerhet.

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

- **Bedre helse for barn/unge og pårørende:** Ettersom vi ikke vet om endelig virkning er positiv eller negativ, har vi valgt å beskrive virkningen som "usikker".
- **Økt jobbtillfredshet:** Kvantum er vurdert til "lite positivt" og enhetsverdi til "middels". Dette resulterer i samfunnsøkonomisk verdi "liten positiv".
- **Dårligere data fra rapportering:** Kvantum er vurdert til "liten negativ" og enhetsverdi til "lav". Samfunnsøkonomisk verdi blir da "ubetydelig/ingen", og vi ser derfor bort ifra denne effekten.

B. Felles plan i helsefellesskapene

Vurdering av prissatte virkninger • Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten

Med bakgrunn i innspill fra helsepersonell legger vi til grunn at 10 prosent av alle henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge får høyere kvalitet, og at kvalitetshevingen gir en tidsbesparelse på en time per henvisning. Dette tilsvarer 3 527 frigjorte timer hvert år, med en årlig verdi på 1,9 mill. kroner, og en samlet verdi på **14 mill. 2025-kr** i løpet av analyseperioden.

- **Økte kostnader i kommunene knyttet til utarbeidelse av plan**
Det året felles plan skal utarbeides for første gang, har vi lagt til grunn at hver kommune må stille med tre representanter i fire møter, der hvert møte varer to timer og at hvert møte krever fem timer med for/etterarbeid. I tillegg har vi anslått at hver kommune må bruke 75 timer på forankring i kommunestyret. I påfølgende år antar vi at det er behov for ett møte på to timer per år, og at nødvendig for-/etterarbeid reduseres til to timer. Vi anslår at kommunestyreforankring vil ta ti timer i hver kommune. Disse antakelsene er basert på erfaringstall fra kommuner og helseforetak med lignende samarbeid. Dette tilsvarer en samlet kostnad på 27 mill. kroner for kommunene i 2029, og 4,3 mill. kroner per år i påfølgende år. Samlet for analyseperioden er kostnaden på **53 mill. 2025-kr**.
- **Økte kostnader i spesialisthelsetjenesten knyttet til utarbeidelse av plan**
Vi har lagt til grunn at hvert helseforetak må stille med to representanter i de samme møtene som kommunene, og at de bruker like lang tid på for-/etterarbeid, igjen basert på erfaringstall fra lignende eksisterende samarbeid. Dette tilsvarer en samlet kostnad på 0,5 mill. kroner i 2029, og i underkant av 100 000 kr for helseforetakene i påfølgende år. Samlet for analyseperioden er kostnaden på **1 mill. 2025-kr**.

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

- **Bedre helse for barn/unge og pårørende:** Kvantum er vurdert til "lite positivt" og enhetsverdi til "høy". Dette resulterer i "middels positiv" samfunnsøkonomisk verdi.

- **Økt jobbtilfredshet:** Kvantum er vurdert til "lite positivt" og enhetsverdi til "middels". Dette resulterer i samfunnsøkonomisk verdi "liten positiv".

C. Avklaringssteam i kommunen

Vurdering av prissatte virkninger • Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten som følge av bedre kvalitet på henvisningene

Vi antar at samarbeidet kan gi betydelig bedre kvalitet på om lag halvparten av henvisningene. Når vi korrigerer for at omtrent en tredjedel av BUP-ene allerede har etablert lignende samarbeid, og dermed har hentet ut nytten av dette, blir andelen 30 prosent. Bedre henvisninger antas å frigjøre en time per pasient. Det gir en samlet nytte på 6 mill. kroner årlig. I nåverdi gir det en samlet verdi på **40 mill. kroner**.

- **Økte kostnader i spesialisthelsetjenesten og kommunene på å delta i møter**
Teamene vil antakeligvis måtte ha noen flere representanter fra kommunene enn teamet som er forankret i helseforetaket. I kostnadsberegningene er det lagt til grunn 1,5 representant fra hver kommune. Det er lagt til grunn 1,5 representant fra hver BUP. Det er antatt en tidsbruk på 2 timer per uke. I tillegg er det beregnet noen oppstartskostnader det første året. Vi har antatt at 50 pst. av teamene kan opprettes i løpet av 2029, 25 pst. av teamene opprettes i 2030, og de resterende 25 pst. blir opprettet i løpet av 2031. Samlet nåverdi av kostnader for kommunene og BUP-ene over ti år knyttet til møtetid og oppstartskostnader beregnes til hhv. **145 mill. kroner og 33 mill. kroner**.
- **Økte kostnader i kommunene fordi de får flere pasienter**
Kostnadsberegningene tar utgangspunkt i 35 000 henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge i 2024, hvor rundt 20 prosent ble avvist. Dersom én fjerdedel av disse avslagene håndteres i kommunen, tilsvarer det ca. 1800 pasienter. Etter korrigering for eksisterende samarbeid i en tredjedel av kommunene, gjenstår om lag 1200 pasienter. Med et anslag på fem timer per pasient, gir dette en nåverdi på **23 mill. kroner** i økte kostnader over ti år, forutsatt at kommunen har kapasitet og relevante tilbud til målgruppen.

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

- **Bedre helse for barn/unge og pårørende:** Kvantum er vurdert til "middels positivt" og enhetsverdi til "høy". Dette resulterer i "stor positiv" samfunnsøkonomisk verdi.
- **Økt jobbtilfredshet:** Kvantum er vurdert til "lite positivt" og enhetsverdi til "middels". Dette resulterer i samfunnsøkonomisk verdi "liten positiv".

D. Avklarings- og inntaksteam forankret i helseforetaket

Vurdering av prissatte virkninger • Økte kostnader i spesialisthelsetjenesten og kommunene på å delta i møter

Kostnadsestimatene baserer seg på ett team per BUP, med tre representanter fra kommunene i hvert team, og at BUP noen steder har delt teamene i to møter. Teamene møtes to timer per uke. I tillegg antar vi at det blir noen ekstra møter i oppstartsåret for å få opprettet samarbeidet. Vi antar at teamene kan opprettes i 2028. Vi antar at teamene kan møtes digitalt og at det ikke er kostnader til reising eller lokaler. Samlet nåverdi av kostnader for kommunene og spesialisthelsetjenesten over ti år knyttet til møtetid og oppstartskostnader beregnes til **70 mill. kroner for hver, til sammen 140 mill. kroner**.

- **Økte kostnader i kommunene fordi de får flere pasienter**
Det forventes at kommunen vil få om lag samme økning i pasienter som i tiltaket som har teamet forankret i kommunen. Kostnadene blir likevel litt høyere fordi teamene i helseforetaket opprettes raskere, så kostnadene kommer tidligere. Det tilsvarer økte kostnader på **25 mill. kroner** over perioden.

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

- **Bedre helse for barn/unge og pårørende:** Kvantum er vurdert til "middels positivt" og enhetsverdi til "høy". Dette resulterer i "stor positiv" samfunnsøkonomisk verdi.

- **Økt jobbtillfredshet:** Kvantum er vurdert til "lite positivt" og enhetsverdi til "middels". Dette resulterer i samfunnsøkonomisk verdi "liten positiv".

E. Kombinasjon av felles plan i helsefellesskapet og avklaringsteam

I kombinasjonsalternativet har vi ikke tatt stilling til hvilket team som benyttes, ettersom samlet nytte og kostnader er relativt like for de to teammodellene. Det er derfor vanskelig å si at den ene teammodellen er bedre enn den andre. Hovedforskjellen er at teamet i helseforetaket medfører relativt høyere kostnader for spesialisthelsetjenesten, mens teamet som er forankret i kommunen gir høyere kostnader for kommunene.

Vurdering av prissatte virkninger • Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten som følge av bedre kvalitet på henvisningene

Dette er beregnet til **mellom 14 og 54 mill. kroner**. Ved valg av teammodellen forankret i helseforetaket, er nytten begrenset til 14 millioner kroner, ettersom helseforetaket ikke oppnår tidsbesparelser når teamet er internt.

Dersom man velger den andre teammodellen, anslås nytten til mellom 40 og 54 mill. kroner. Det er høyere enn ved kun ett tiltak, men lavere enn summen av tiltakene hver for seg, noe som indikerer en viss grad av overlapp i effektene.

- **Kostnadene antas å tilsvare summen av kostnadene for felles plan og valgt teammodell**

Kommunene: **148–220 mill. kroner** over ti år, avhengig av valgt teammodell

Spesialisthelsetjenesten: **34–71 mill. kroner** over ti år, avhengig av valgt teammodell

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

- **Bedre helse for barn/unge og pårørende:** Kvantum er vurdert til "stort positivt" og enhetsverdi til "høy". Dette resulterer i "meget stor positiv" samfunnsøkonomisk verdi.
- **Økt jobbtillfredshet:** Kvantum er vurdert til "middels positivt" og enhetsverdi til "middels". Dette resulterer i samfunnsøkonomisk verdi "middels positiv".

Kostnader til pilot og følgeevaluering

Som det fremgår av anbefalingen, foreslår Helsedirektoratet at tiltaket piloteres i én eller flere kommuner og helseforetak, og at piloten evalueres. Det antas at pilot og evaluering vil ta ca. 3 år. Samlede kostnader til oppfølging av pilot, følgeevaluering og oppfølging av følgeevaluering er beregnet å koste **13 mill. kroner**. Dersom man velger å pilotere og evaluere vil disse kostnadene komme uavhengig av valgt tiltak. Kostnadene er derfor lagt til i alle tiltaksalternativene i samletabellen. Pilotering vil også medføre en forskyving av kostnader for de kommunene og helseforetakene som deltar. Det vil medføre at kostnadene ved selve tiltaket for de som deltar i piloten vil oppstå fra 2026 i stedet for 2029. I tillegg er det kanskje behov for lokale prosjektroller som følger opp piloteringen. Dette må vurderes nærmere i planleggingen av en eventuell pilot. Denne mulige ekstra kostnaden er ikke inkludert som en prissatt virkning i analysen, og kommer i tillegg.

Fordelingsvirkninger

Nytten fra tiltakene vil tilfalle barn og unge og deres pårørende, helsepersonell i form av økt jobbtrivsel, og spesialisthelsetjenesten i form av frigjort tid. Kostnadene vil i all hovedsak tilfalle kommunene og spesialisthelsetjenesten. Siden kommunene får mesteparten av kostnadene og ikke så store direkte nyttevirksomheter, kan det være ønskelig med en tilskuddsordning for å stimulere kommunene til å delta i samarbeidet. Rekrutterings- og samhandlingstilskuddet som ble opprettet i 2024 er et eksempel på tilskudd som ev. kan benyttes til dette. Bevilgningen er foreslått satt til 326 mill. kroner i 2026.

7.3 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Våre beregninger av nytte og kostnader ved tiltaksalternativene er oppsummert i tabellen under. Grønne tall indikerer nytte, og røde tall indikerer kostnader.

Tabell 7-2: Oppsummering av prissatte virkninger, summert for analyseperioden på 10 år, i millioner 2025 kroner, ikkeprissatte virkninger og rangering av tiltak

Nytte- og kostnadselement	Økt andel ramme PHBU	Felles plan i helsefellesskapet	Avklaringssteam i kommunen	Avklarings- og inntaksteam	Kombinasjon team, felles plan
PRISSATTE VIRKNINGER					
KOSTNADER					
Økte kostnader i kommunen	0	53	168	96	148 - 220
Økte kostnader i spesialisthelsetjenesten	0	1	33	70	34 - 71
Økte kostnader i forvaltningen	13	13	13	13	13
SUM KOSTNADER	13	66	213	179	245 - 279
NYTTE					
Frigjort tid i spesialisthelsetjenesten	18 - 55	14	40	0	14 - 54
SUM NYTTE	18 - 55	14	40	0	14 - 54
Skattefinansieringskostnad/-gevinst	1 - 9	10	35	36	45 - 46
NETTO NÅVERDI PRISSATTE VIRKNINGER	6 - 51	63	207	214	270 - 277
IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER					
Bedre helse for barn/unge og pårørende	Usikker	Middels positiv	Stor positiv	Stor positiv	Meget stor positiv
Økt jobbtilfredshet	Liten positiv	Liten positiv	Liten positiv	Liten positiv	Middels positiv
Ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet	Usikker	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
RANGERING	4	3	2	2	1

Tiltaket med størst netto nåverdi av prissatte virkninger er økt andel rammefinansiering i spesialisthelsetjenesten. Merk imidlertid at denne effekten er vanskelig å anslå og dermed usikker. Effekten på helse for barn og unge og pårørende er også svært usikker. Dette fører til at det er usikkerhet knyttet til om dette tiltaket er til barnets beste, jfr. drøfting av prinsipielle spørsmål i kapittel 6. På grunn av usikkerheten knyttet til effekten på barn og unges helse, rangerer vi ikke tiltaket som nummer én, til tross for de forventede nyttevirkningene knyttet til frigjort tid brukt på koding. Dette er også årsaken til at vi ikke inkluderer dette tiltaket i en kombinasjon med øvrige tiltak.

Når det gjelder de to teammodellene, er samlede kostnader og nyttevirkninger såpass like at vi ikke med rimelig sikkerhet kan si at den ene teammodellen er bedre enn den andre. Kommunale team har trolig høyere nyttepotensial og tydeliggjør kommunens ansvar, men er mer krevende å etablere og gir større variasjon i effekt på grunn av ulikheter mellom kommuner. Kostnadmessig er hovedforskjellen at teamet i helseforetaket medfører relativt høyere kostnader for spesialisthelsetjenesten, mens teamet som er forankret i kommunen gir høyere kostnader for kommunene. Vi har rangert disse teammodellene likt.

Vi vurderer at den samfunnsøkonomiske nytten som oppstår når man slår sammen flere av tiltakene er såpass stor at den overstiger de økte kostnadene. Kombinasjonstiltaket med felles plan og én av teammodellene vurderes som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltaket. Kombinasjonstiltaket gir prissatt nytte i form av frigjort tid i spesialisthelsetjenesten og store ikke-prissatte nyttevirkninger i form av bedre helse for barn/unge og pårørende, samt økt jobbtilfredshet for helsepersonell. Den helhetlige tilnærmingen antas å sørge for bredt eierskap, bedre koordinering og mer målrettet innsats. Selv om tiltaket medfører økte kostnader, særlig i kommunen, er vår vurdering at dette oppveies av nyttevirkningene. Derfor rangeres det som det mest lønnsomme alternativet.

7.4 Usikkerhetsanalyse

Dette er en tidligfase-utredning med en overordnet vurdering av ulike tiltaksalternativer. Det medfører betydelig usikkerhet i forutsetningene og i verdsettingen av kostnader og nytte. Flere anslag bygger på intervjuer og skjønn, spesielt estimater for frigjort tid, effekter for barn og unge og jobbtilfredshet. Store variasjoner i organisering og samarbeid mellom kommuner og helseforetak gjør det vanskelig å generalisere effektene. Kostnadsberegningene er basert på antakelser om tidsbruk som kan variere i praksis, og det er usikkerhet om tiltakene faktisk gir forventet effekt. Tidspunkt for iverksettelse er også usikkert, men har begrenset betydning for lønnsomheten.

Den prissatte usikkerheten er belyst gjennom dekningsanalyser og scenarioanalyser i vedlegg 7. Dekningsanalysen viser hvor stor nytte hvert barn minst må oppnå for at tiltakene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, gitt de samlede kostnadene. Dette gir et bilde av hvor følsom lønnsomheten er for antall barn som faktisk får effekt. Vi har målt nødvendig nytte både i kroner og i QALY (kvalitetsjusterte leveår). Jo flere barn som får effekt, desto lavere nødvendig nytte per barn. For eksempel vil nødvendig nytte per barn være relativt lav dersom man forventer at 50 000 barn oppnår effekt i løpet av en tiårsperiode (fra 1 700 til 7 400 kroner avhengig av tiltak).

For å teste robustheten har vi utarbeidet to scenarier med mer pessimistiske forutsetninger enn i basisberegningen; ett hvor nytten reduseres med 20 prosent og kostnader øker med 20 prosent, og ett hvor nytten reduseres med 50 prosent og kostnader øker med 50 prosent. I det mest pessimistiske scenariet reduseres nåverdien av de prissatte virkningene betydelig. Hvis 50 000 barn oppnår effekt, må minimum oppnådd nytte per barn være 12 300 kroner for at kombinasjonstiltaket med felles plan og team skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt under det mest pessimistiske scenariet.

Til tross for disse usikkerhetsmomentene vurderer vi det som sannsynlig at det er tilstrekkelig antall barn som vil nås med tiltakene, slik at samlet nytte overstiger kostnadene også i disse mer pessimistiske scenariene. Dette illustreres ved at vi har vurdert den samfunnsøkonomiske verdien av bedre helse for barn/unge og deres pårørende til "meget stor positiv". Deknings- og scenarioanalysene endrer derfor ikke rangeringen av tiltakene eller hovedkonklusjonen om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men de synliggjør hvor følsomme resultatene er for antall berørte barn og størrelsen på nytten og kostnadene.

Kapittel 8

8. Anbefaling og forutsetninger for en vellykket gjennomføring

Anbefaling

Helsedirektoratet anbefaler et kombinasjonstiltak som inkluderer felles plan i helsefelleskapet og én av teammodellene. Tiltaket gir meget stor positiv effekt på helse og livskvalitet for barn, unge og pårørende, og middels stor positiv effekt på jobbtilfredshet. Samtidig frigjør tiltaket noe tid i spesialisthelsetjenesten. Kombinasjonen vurderes som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt til tross for høyere kostnader.

En felles plan i helsefelleskapene kan bidra til felles forståelse for ansvar og handlingsrom og gi økt oppmerksomhet på psykisk helse og rus i kommunen. Planen gir et godt grunnlag for samarbeid om konkrete saker i avklaringsteamene. Samarbeid på flere arenaer kan også bidra til kulturbygging og en sterkere opplevelse av felles mål, noe som øker

sannsynligheten for å realisere nytten. Basert på dette vurderer vi både at flere barn og unge kan få hjelp gjennom kombinasjonstiltaket, og at effekten for flere av dem kan bli større enn ved tiltakene hver for seg.

Det anbefales videre at tiltaket piloteres i én eller flere kommuner og helseforetak, og at piloten(e) evalueres. Pilotering og evaluering kan redusere usikkerheten gjennom å teste tiltakets gjennomførbarhet og gi mer presise estimater for kostnader og nytte. Det gir bedre grunnlag for å vurdere faktisk effekt, avdekke samhandlingsutfordringer og justere tiltaket før eventuell bred implementering. Under pilotering bør kommunene og helseforetaket kunne velge mellom de to teammodellene (team forankret i helseforetaket eller i kommunen) ut fra lokal organisering, eksisterende samarbeid, kapasitet og preferanser. Denne valgfriheten vil kunne være hensiktsmessig også i en eventuell bredere innføring, med mindre pilotering og evaluering viser at den ene teammodellen er vesentlig bedre enn den andre med tanke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Forutsetninger for en vellykket gjennomføring

Som nevnt, anbefaler Helsedirektoratet at tiltaket piloteres i én eller flere kommuner og helseforetak, og at piloten evalueres. Forutsetninger for en vellykket pilotering vil være god planlegging og forankring i kommunene og helseforetakene som skal prøve ut tiltaket.

En vellykket gjennomføring av pilot og videre innføring forutsetter **god kommunikasjon og forankring** med kommuner og spesialisthelsetjenesten. Særlig kan det være viktig å kommunisere målsetting for tiltakene og tilnærming på en klok måte. Videre er det viktig at **roller og ansvar** for et felles avklaringsteam tidlig gås opp mellom kommuner og helseforetaket i hvert enkelt helseforetaksområde. Det vil i forbindelse med piloteringen være behov for planlegging og bistand fra statlige myndigheter, blant annet knyttet til å utarbeide forskrift hjemlet i forsøksloven som gjør nødvendige justeringer i pasient- og brukerrettighetsloven, for kommuner og helseforetak som velger teammodellen som forankres i helseforetaket i piloten. Dersom teammodellen som innebærer lovendringer skal breddes videre, vil det være behov for god planlegging og kommunikasjon om lovendringene og konsekvensene av disse.

Det er i tillegg viktig at både kommuner og spesialisthelsetjeneste setter av **tilstrekkelig tid og ressurser** til å bli enige om felles plan, og til å etablere og drifte felles team. **God lederforankring** er en forutsetning for prioritering av samarbeid og ressursbruk, herunder også kontinuerlig arbeid med kultur for samarbeid.

For mange kommuner vil innføring av tiltakene, og særlig den kommunale teammodellen, være ressurskrevende. For noen vil en tilføring av midler, for eksempel gjennom en **tilskuddsordning**, være en forutsetning for implementering. Tilskuddsmidler vil også kunne fremskynde implementering av tiltakene andre steder.

Se vedlegg 5 for ytterligere beskrivelse av forutsetninger for de ulike tiltaksforslagene.

Kapittel 9

9. Litteraturliste

1. Helsedirektoratet. (2024). Tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024. Hentet fra <https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f63d7d01d64def982cb7c8ce1eeb64/tildelingsbrev-tilhelsedirektoratet-for-2024.pdf>

2. Helse- og omsorgsdepartementet. (2019). *Meld. St. 7 (2019–2020): Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. Kapittel 3: En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste – Hvor vil vi?* Regjeringen.
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=1>
3. Helse Nord RHF. (2023, 14. november). *Tid for samordning: Delrapport 5. Rapport fra arbeidsgruppe 5 – Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten* [PDF]. Helse Nord RHF.
<https://personsentrert.helsekompetanse.no/wp-content/uploads/2023/12/20231114-rapport-fra-arbeidsgruppe-5-samordning-av-primar-og-spesialisthelsetjenesten.pdf>
4. Riksrevisjonen. (2021). Undersøkelse av psykiske helsetjenester, Dokument 3:13 (2020–2021).
<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-psykiske-helsetjenester/>
5. Helse- og omsorgsdepartementet. (2023a). Meld. St. 23 (2022–2023): Opptappingsplan for psykisk helse (2023–2033). <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-2022-2023/id2961234/>
6. Helse- og omsorgsdepartementet. (2024a). Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan-2024-2027/id2961234/>
7. Helse- og omsorgsdepartementet. (2024b). Meld. St. 5 (2024–2025): Trygghet, fellesskap og verdighet – Forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet. Del I – en ny politikk for forebygging, skadereduksjon og behandling. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-2024-2025/id2983623/>
8. Folkehelseinstituttet. (2025). Temautgave: Barn og unges psykiske helse. Folkehelseinstituttet.
https://www.fhi.no/contentassets/b5b3603ec4794c5cb0c8651589b359f8/temautgave-barn-og-ungespsykiske-helse_2025.pdf
9. Bakken, A., Frøyland, L. R., Sletten, M. A., & Torsheim, T. (2024). Ungdata 2024: Nasjonale resultater. NOVA, OsloMet.
https://oda.oslomet.no/odaxmlui/bitstream/handle/11250/3145138/Ungdata2024_NasjonaleResultater_UU.pdf
10. Finansdepartementet. (2024). Meld. St. 31 (2023–2024): Perspektivmeldingen 2024.
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20232024/id3049290/>
11. SINTEF. (2024). Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (IS-24/8). SINTEF.
12. NOU 2023: 4. (2023). [Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste]. Helse- og omsorgsdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/>
13. Helsedirektoratet. (2019a). Hvor skal man begynne? Et utfordringsbilde blant familier med barn og unge som behøver sammensatte offentlige tjenester. Helsedirektoratet.
14. Helsedirektoratet. (2021). Alvorlig sykt barn – erfaringer med tjenester og samhandling. Helsedirektoratet.
15. Halogen. (2023). Kunnskapsgrunnlag helhetlig innsats: En kartlegging av erfaringer og kunnskap med relevans for det målrettede samfunnsoppdraget for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Design og arkitektur Norge (DOGA). https://doga.no/globalassets/dokumenter/filer/kartlegging-2023_halogen_malrettetsamfunnsoppdrag.pdf
16. Helsedirektoratet. (2017). Veileder for oppsøkende tjenester for ungdom. Helsedirektoratet.
17. Helsedirektoratet. (2025). Rapport om psykisk helse og rusmiddelbruk blant ungdom. Helsedirektoratet.
18. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). (2019). Kartlegging av helsetilbudet til barn og unge i psykisk helsevern. <https://www.ukom.no/rapporter/2019/kartlegging-av-helsetilbudet-til-barn-og-unge-i-psykisk-helsevern>
19. Helsedirektoratet. (2020). 0–24-samarbeidet: Samordnet innsats for utsatte barn og unge. Helsedirektoratet
20. Barneombudet. (2025). De er våre barn. Barneombudet.
21. Helsedirektoratet. (2023). *Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012–2022*. Helsedirektoratet. <https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kvalitativ-forskning-pabrukermedvirkning-innen-psykisk-helse-og-rus-i-norden-og-sapmi-2012-2022> [helsedirektoratet.no]
22. Oslo kommune. (2023). Løsningsrapport Ung Arena. Oslo kommune.
23. Barneombudet. (2020). *Jeg skulle hatt BUP i en koffert: En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov*. Barneombudet.
<https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Jeg-skulle-hatt-BUP-i-en-koffert.pdf>

24. Barneombudet. (2022). *Hvem skal jeg snakke med nå? Psykisk helsehjelp til barn og unge i kommunene*. Barneombudet. <https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Hvemskal-jeg-snakke-med-na.pdf>
25. Hatling, T. (red.). (2021). *Utredning om FACT Ung i Norge*. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). <https://napha.no/attachment.ap?id=3266>
26. Helse- og omsorgsdepartementet. (2023). *NOU 2023: 8 – Fellesskapets sykehus: Styring, finansiering, samhandling og ledelse*. Regjeringen. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20238/id2967792/>
27. Finansdepartementet. (2021). *R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser*. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2021.pdf
28. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). (2023). *Veileder i samfunnsøkonomiske analyser*. DFØ. https://www.dfo.no/sites/default/files/2023-06/Veileder-i-samfunnsokonomiskeanalyser_210623_DFO.pdf
29. Helseøkonomisk analyse A/S (2022). *Kunnskapsoppsummering om erfaringer med innsatsstyrt finansiering (ISF)*. Rapport 2022:2.